

Méthodologie
phénoménologie / analyse existentielle

Support TD

PHILIPPE SPOLJAR

Courriel : philippe.spoljar@u-picardie.fr

Organisation des TD

Objectifs

L'enjeu des TD est de transformer la méthode présentée en CM en savoir-faire concret, en pratiquant progressivement chacune des étapes. Il s'agit d'abord d'entrer dans la posture de la clinique phénoménologique :

- comprendre concrètement la démarche clinique (en phénoménologie / analyse existentielle)
- distinguer description / interprétation / diagnostic

À la fin des TD, chaque étudiant doit être capable de :

- décrire un vécu ;
- l'organiser selon les existentiels ;
- identifier une tension structurante ;
- formuler une structure de vécu

Supports et modalités de travail

Différents types de supports sont utilisés pour varier les apprentissages : vignettes cliniques, extraits d'entretien, récits en première personne, textes littéraires adaptés.

Une partie du travail peut se faire en binôme :

- relecture critique
- vérification de l'ancrage textuel
- comparaison de plusieurs structures de vécu (validité intersubjective).

Consignes générales

- rester au plus près du texte
- utiliser des formulations descriptives
- ne pas utiliser de catégories sémiologiques ou psychopathologiques prématurées
- éviter toute interprétation « psychologisante » ou diagnostique :

Formulations à éviter	Formulations attendues
« il est anxieux »	« la situation est vécue comme... »
« elle a un trouble de... »	« le monde apparaît comme... »
« il manque de confiance »	« le corps est mobilisé de telle manière... »

Critères d'évaluation du travail en TD

- Fidélité au matériau : les analyses sont ancrées dans le texte
- Respect de la posture clinique : absence d'explication causale ou diagnostique
- Qualité descriptive : précision, finesse, rigueur
- Organisation du matériau : utilisation pertinente des dimensions du vécu
- Pertinence des tensions : caractère transversal et dynamique
- Cohérence de la structure de vécu : synthèse claire et articulée

Fiches de méthode

Principes de l'analyse phénoménologique – synthèse et formalisation pour les TD

L'analyse phénoménologique et existentielle d'un cas clinique vise à comprendre comment une existence se tient, à partir de la manière dont elle est vécue.

Elle ne cherche pas d'abord :

- ce que le sujet « est » ;
- ce que le sujet « a » ;
- pourquoi il est ainsi.

> Elle cherche d'abord :

- ce que le sujet vit ;
- comment son monde lui apparaît ;
- comment il se rapporte à son corps, au temps, à l'espace, aux autres, à lui-même et au monde ;
- comment il se maintient dans l'existence.

Cette fiche résume l'ensemble de la démarche. Elle sert de carte générale pour les TD. Elle ne doit pas être utilisée intégralement à chaque séance : chaque TD active prioritairement une partie de la méthode.

La méthode repose sur quatre opérations successives, qui doivent rester distinctes :

TD1 : DÉCRIRE - Repérer le vécu brut tel qu'il apparaît dans le matériau

TD2 : ORGANISER - Classer les indices selon les dimensions du vécu.

TD3 : ARTICULER - Dégager une ou plusieurs tensions structurantes.

TD4 : SYNTHÉTISER - Formuler une structure de vécu

TD5 : préparer l'examen.

La fiche n'est donc pas une grille à remplir mécaniquement. Elle constitue un appui pour parcourir les étapes de l'analyse sans oublier un moment important. L'objectif n'est pas de remplir toutes les cases, mais de rester attentif à la manière dont le vécu apparaît, s'organise, puis se structure.

Etape 1. Décrire le vécu. Repérage phénoménologique

Question directrice : *Comment cette personne vit-elle ce qu'elle vit (tel que cela apparaît dans le texte) ?*

À cette étape, on reste au plus près du matériau. On ne cherche pas encore à expliquer, interpréter ou diagnostiquer. On relève uniquement ce qui apparaît, notamment :

- les formulations subjectives ;
- les affects explicitement présents ;
- les perceptions ;
- les gestes ;
- les postures ;
- les images ;
- les rythmes du récit ;
- les silences, hésitations ou ruptures ;
- les répétitions ;

- les bascules ;
- les modalités d'action : pouvoir, ne pas pouvoir, attendre, éviter, répéter, se retenir, subir ;
- les indices temporels, spatiaux, corporels, relationnels, attentionnels. Etc.

On peut citer de courts morceaux de phrases, ou les reformuler très légèrement.

Il s'agit de décrire les modalités des actes et des situations, non d'inventer leurs causes ou leurs intentions supposées.

On n'interprète pas ce que le sujet pense ; on décrit comment la situation, le monde, le corps, les autres ou soi-même apparaissent pour lui.

> *Indices cliniques repérés :*

...
...
...

Première impression descriptive, sans interprétation :

Le vécu semble marqué par :

.....
.....
.....

Exemples de formulations attendues :

- « Le sujet décrit une impossibilité de passer à l'action. »
- « Le temps apparaît répétitif et faiblement orienté vers l'avenir. »
- « Le corps est retenu, peu mobilisé dans l'action. »
- « La relation à autrui est présente, mais peu investie. »
- « Le monde apparaît comme peu mobilisateur. »

Fonction de l'étape 1 :

- L'étape 1 agit comme une discipline méthodologique : elle empêche l'interprétation prématurée.
- Elle peut sembler proche de la paraphrase, mais elle prépare les étapes suivantes. Son utilité apparaît surtout lorsque les indices relevés sont ensuite organisés selon les dimensions du vécu, puis articulés dans une tension structurante.

Etape 2. Organiser selon les dimensions du vécu. Les existentiels

Question directrice : *Dans quelles dimensions de l'existence les indices repérés prennent-ils sens ?*

À cette étape, on ne se contente plus de lister les éléments du texte. On commence à organiser le matériau.

Les existentiels sont des axes de description du vécu. Ils ne sont pas des symptômes, ni des diagnostics, ni des traits de personnalité.

Les six dimensions principales :

Dimension	Question simple	Indices possibles	Formulation attendue
Temporalité	Comment le temps est-il vécu ?	attente, répétition, urgence, rupture, avenir fermé, passé envahissant	Le temps apparaît comme...
Spatialité	Comment le sujet prend-il place ?	retrait, enfermement, exposition, refuge, errance, impossibilité de partir	L'espace est vécu comme...

Corporéité	Comment le corps est-il engagé ou vécu ?	fatigue, tension, agitation, immobilité, retenue, effacement	Le corps semble...
Altérité	Comment autrui apparaît-il ?	soutien, menace, absence, jugement, intrusion, attente, distance	L'autre apparaît comme...
Ipséité	Comment le sujet se rapporte-t-il à lui-même ?	continuité, étrangeté, effacement, indétermination, perte de maîtrise	Le rapport à soi est marqué par...
Mondanéité	Comment le monde se donne-t-il ?	monde vide, saturé, menaçant, fermé, peu mobilisateur, trop intense	Le monde apparaît comme...

Pour chaque dimension pertinente, il faut :

- rassembler les indices du texte qui s'y rapportent ;
- formuler l'organisation du vécu dans cette dimension.

Il ne s'agit pas de remplir toutes les dimensions, mais de repérer celles qui sont réellement présentes dans le matériau : trois dimensions bien justifiées valent mieux que six dimensions artificiellement remplies.

Organisation du vécu par dimension :

- *Temporalité*

. Indices :

. Organisation du vécu :

- *Spatialité*

. Indices :

. Organisation du vécu :

Corporéité

. Indices :

. Organisation du vécu :

Altérité

. Indices :

. Organisation du vécu :

Ipséité

. Indices :

. Organisation du vécu :

Mondanéité

. Indices :

. Organisation du vécu :

Éléments qui traversent plusieurs dimensions :

...

...

...

Par exemple : « l'autre est trop près » prend sens dans l'espace, le temps, l'altérité et l'ipséité

Objectif de l'étape 2 : donner une lisibilité structurée au vécu, sans réduire le texte à une grille et sans découper artificiellement l'expérience.

Etape 3. Dégager les tensions structurantes

Question directrice : *Qu'est-ce qui traverse plusieurs dimensions du vécu ?*

À cette étape, on cherche ce qui organise dynamiquement l'expérience.

Une tension structurante est une polarité dynamique, présente dans plusieurs dimensions du vécu. Elle permet de comprendre comment le sujet se maintient dans l'existence, mais aussi ce que cette organisation limite.

Une tension structurante n'est pas :

- un diagnostic
- un symptôme
- un trait de personnalité
- un simple thème
- un déficit
- une explication causale

Une tension structurante est :

- transversale
- dynamique
- descriptive
- ancrée dans le texte
- capable de montrer ce que l'organisation du vécu permet et ce qu'elle limite

Exemples de tensions possibles :

Tension possible	Formulation à éviter
protection / exposition	anxiété sociale
présence / retrait	isolement pathologique
maîtrise / débordement	trouble anxieux
intention d'agir / impossibilité d'agir	manque de motivation

continuité / rupture	crise identitaire
attente de l'autre / impossibilité de s'engager	dépendance affective
monde familial / monde devenu étrange	délire
engagement / désengagement	burn-out

Il peut exister plusieurs tensions dans un même matériau. Dans ce cas, il faut éviter les listes plates. On peut distinguer :

- une tension principale
- une tension secondaire
- une tension dérivée

Fiche de travail

Nom de la tension :

Elle traverse :

Polarité 1 :

Polarité 2 :

Ce que cette tension permet :

Ce qu'elle limite :

Elle traverse notamment :

- le rapport au
- le rapport au
- le rapport au

Etape 4. Formuler synthétiquement la structure du vécu

Question directrice : Quelle cohérence d'ensemble se dégage du vécu ?

La structure de vécu est une formulation synthétique. Elle rend compte de la manière dont l'expérience s'organise dans son ensemble.

Elle doit articuler :

- les indices principaux
- les dimensions dominantes
- la ou les tensions structurantes
- ce que cette organisation permet
- ce qu'elle limite.

La structure de vécu doit rendre compte :

- de la cohérence du vécu
- de sa logique existentielle
- de la manière dont le sujet se maintient dans l'existence
- du coût ou des limites de cette manière de se maintenir

Elle doit rester :

- descriptive
- synthétique
- ancrée dans le matériau
- sans diagnostic
- sans causalité supposée
- sans jugement

Patron de formulation :

- Le vécu semble organisé autour de...
- Cette organisation apparaît notamment dans le rapport au temps..., au corps..., à l'espace..., à l'autre..., à soi..., au monde...
- La tension principale oppose...
- Cette tension permet...
- Elle limite cependant...
- L'ensemble dessine une manière d'exister caractérisée par...

On peut formuler la structure de vécu ainsi :

.....

Cette formulation s'appuie sur les éléments suivants du texte :

...
 ...
 ...

Points de vigilance méthodologique

Les erreurs les plus fréquentes consistent à :

- quitter trop vite le niveau descriptif
- transformer les dimensions du vécu en catégories psychologiques
- ou formuler une synthèse insuffisamment ancrée dans le matériau.

Entrer trop rapidement par le diagnostic

À éviter : « *Il est dépressif.* »

À formuler plutôt : « *Le temps apparaît ralenti, répétitif et faiblement orienté vers l'avenir.* »

Le diagnostic peut éventuellement être discuté dans un second temps, mais il ne doit pas organiser la première lecture du matériau.

Transformer une tension en catégorie clinique

À éviter : « *Le sujet est anxieux.* »

À formuler plutôt : « *Le vécu est organisé autour d'une tension entre exposition au monde et recherche de protection.* »

Une tension structurante n'est ni un trouble, ni un symptôme, ni un trait psychologique. Elle décrit une polarité dynamique dans l'organisation du vécu.

Confondre "thème" et "tension"

À éviter : « *Le thème principal est le retrait.* »

À formuler plutôt : « *La tension semble opposer protection de soi et exposition au monde.* »

A distinguer :

- un *thème* désigne ce dont il est question.
- une *tension* indique une dynamique : elle montre comment plusieurs dimensions du vécu s'articulent entre elles.

Remplir artificiellement toutes les dimensions

Il ne faut pas nécessairement renseigner le temps, l'espace, le corps, autrui, soi et le monde.

> On retient les dimensions réellement soutenues par le texte.

Trois dimensions précisément justifiées valent mieux que six dimensions faiblement étayées.

Paraphraser sans organiser

À éviter : « *Il dit qu'il ne sort pas, qu'il reste chez lui, qu'il ne voit personne.* »

À formuler plutôt : « *Les indices convergent vers un rapport à l'espace organisé par le retrait, et un rapport à l'autre marqué par une présence sociale réduite.* »

Distinguer :

- la paraphrase reste au niveau de la répétition du texte
- l'analyse phénoménologique doit organiser les indices sans les transformer en explication causale.

Formuler une cause au lieu d'une description

À éviter : « *Il ne sort pas parce qu'il a peur des autres.* »

À formuler plutôt : « *La sortie est difficilement habitable ; l'espace extérieur s'associe à une forme d'exposition.* »

L'objectif n'est pas d'expliquer pourquoi le sujet vit les choses ainsi, mais de décrire comment la situation se donne pour lui.

Déduire une intention non présente dans le matériau

À éviter : « *Il refuse d'aller vers les autres.* »

À formuler plutôt : « *Le lien à autrui est difficile à investir ; la relation est associée à une forme d'exposition ou de mise en difficulté.* »

Une intention ne doit pas être supposée si elle n'est pas soutenue par le texte. On décrit les modalités du vécu plutôt que les motivations cachées.

« Psychologiser » trop vite

À éviter : « *Elle manque de confiance.* »

À formuler plutôt : « *Le rapport à soi est fragile, marqué par une difficulté à se sentir légitime dans la situation.* »

Distinguer :

- les formulations psychologisantes réduisent le vécu à une caractéristique du sujet.
- l'analyse phénoménologique cherche plutôt à décrire une manière de se rapporter à soi, aux autres et au monde.

Multiplier les tensions sans les hiérarchiser

À éviter : « *Il y a une tension retrait/exposition, une tension action/inaction, une tension soi/autrui, une tension monde fermé/monde ouvert.* »

À formuler plutôt : « *La tension principale semble opposer protection de soi et exposition au monde. Elle se décline dans le rapport à l'espace, au corps et à autrui.* »

Lorsqu'il existe plusieurs tensions, il faut distinguer la tension principale des tensions secondaires ou dérivées. Une liste de tensions ne constitue pas encore une structure de vécu.

Produire une structure de vécu trop générale

À éviter : « *Le sujet est en difficulté dans son rapport au monde et aux autres.* »

À formuler plutôt : « *Le vécu est organisé autour d'une recherche de protection face à un monde éprouvé comme exposant. Cette organisation permet de préserver une forme de sécurité, mais limite l'engagement dans les relations et dans l'action.* »

Une structure de vécu doit :

- articuler plusieurs dimensions
- préciser la tension dominante
- et indiquer ce que cette organisation permet et limite.

Vérification finale

Avant de conclure, vérifier que l'analyse :

- reste précisément ancrée dans le texte ;
- ne commence pas par un diagnostic ;
- distingue description, organisation, tension et structure ;
- retient les dimensions réellement soutenues par le matériau ;
- articule plusieurs dimensions du vécu ;
- formule une tension plutôt qu'un simple thème ;
- hiérarchise les tensions lorsqu'il y en a plusieurs ;
- évite les intentions supposées et les explications causales ;
- indique ce que l'organisation du vécu permet et ce qu'elle limite.

Si ces critères sont respectés, l'analyse reste conforme à la démarche phénoménologique.

Exemple

Observation

« Depuis quelque temps, je ne me reconnais plus entièrement dans mes gestes. Je les accomplis, mais sans y être vraiment présent.

Mon corps me répond, mais il ne m'appartient plus tout à fait. Je le regarde fonctionner avec une attention inquiète. Les actes les plus simples prennent une étrangeté nouvelle.

Cette sensation ne vient pas brutalement. Elle s'installe peu à peu, sans douleur, sans crise.

Je continue à vivre comme avant, mais avec le sentiment d'être dédoublé. Je suis là, et en même temps à côté de moi.

Le temps n'est pas rompu. Il s'écoule normalement. C'est moi qui ne m'y reconnais plus. »

Étape 1 — Décrire le vécu. Repérage phénoménologique

Question directrice : Comment cette personne vit-elle ce qu'elle vit, tel que cela apparaît dans le texte ?

Indices cliniques :

- Le sujet décrit une modification progressive de son rapport à lui-même : « Depuis quelque temps ».
- Il ne se reconnaît plus entièrement dans ses gestes : « je ne me reconnais plus entièrement dans mes gestes ».
- Les gestes continuent d'être accomplis : « Je les accomplis ».
- Mais ces gestes ne sont plus pleinement habités : « sans y être vraiment présent ».
- Le corps continue à répondre : « Mon corps me répond ».
- Mais ce corps n'est plus vécu comme pleinement sien : « il ne m'appartient plus tout à fait ».
- Le sujet observe son propre corps fonctionner : « Je le regarde fonctionner ».
- Cette observation est accompagnée d'une inquiétude : « avec une attention inquiète ».
- Les actes ordinaires deviennent étranges : « Les actes les plus simples prennent une étrangeté nouvelle ».
- La transformation est progressive : « Cette sensation ne vient pas brutalement. Elle s'installe peu à peu ».
- Elle n'est pas décrite comme une crise aiguë : « sans douleur, sans crise ».
- Le sujet continue à vivre de manière apparemment ordinaire : « Je continue à vivre comme avant ».
- Mais il éprouve un dédoublement : « avec le sentiment d'être dédoublé ».
- Il se décrit comme présent et en même temps séparé de lui-même : « Je suis là, et en même temps à côté de moi ».
- Le temps n'est pas vécu comme désorganisé : « Le temps n'est pas rompu. Il s'écoule normalement ».
- Le problème porte surtout sur la reconnaissance de soi : « C'est moi qui ne m'y reconnais plus ».

Première impression descriptive, sans interprétation :

Le vécu semble marqué par une altération progressive du rapport à soi et au corps. Le sujet continue à agir et à vivre dans une continuité apparente, mais il ne se reconnaît plus pleinement dans ce qu'il fait. Ses gestes, son corps et ses actes restent présents et fonctionnels, mais ils prennent une qualité d'étrangeté. L'expérience n'est pas décrite comme une rupture brutale, mais comme un décalage progressif entre présence, action et sentiment d'être soi.

Étape 2 — Organiser selon les dimensions du vécu

Organisation du vécu par dimension

Temporalité

Indices cliniques : « Depuis quelque temps » ; « Cette sensation ne vient pas brutalement » ; « Elle s'installe peu à peu » ; « Je continue à vivre comme avant » ; « Le temps n'est pas rompu. Il s'écoule normalement ».

Organisation du vécu : Le rapport au temps n'est pas marqué par une rupture brutale. Le temps continue à s'écouler normalement, et la vie paraît se poursuivre « comme avant ». Cependant, une transformation progressive s'installe dans cette continuité. La temporalité est donc organisée par une tension entre continuité apparente et modification progressive du rapport à soi.

Spatialité

Indices cliniques : « Je le regarde fonctionner » ; « Je suis là, et en même temps à côté de moi ».

Organisation du vécu : La spatialité n'est pas décrite par des lieux précis. Elle apparaît plutôt comme une distance à soi. Le sujet se vit comme présent, mais également « à côté » de lui-même. L'espace vécu prend donc la forme d'un décalage interne : le sujet n'est pas absent de la situation, mais il ne coïncide plus pleinement avec sa propre présence.

Corporéité

Indices cliniques : « je ne me reconnais plus entièrement dans mes gestes » ; « Je les accomplis » ; « Mon corps me répond » ; « il ne m'appartient plus tout à fait » ; « Je le regarde fonctionner » ; « Les actes les plus simples prennent une étrangeté nouvelle ».

Organisation du vécu : Le corps reste fonctionnel : il répond, il accomplit des gestes, il permet la poursuite des actes ordinaires. Mais il n'est plus vécu comme pleinement approprié. Le sujet observe son corps fonctionner avec inquiétude, comme si ses gestes lui appartenaient moins directement. La corporéité est donc marquée par un corps encore opérant, mais partiellement étranger.

Altérité

Indices cliniques : Aucune figure d'autrui n'est directement présente dans l'extrait.

Organisation du vécu : Le rapport à autrui n'est pas une dimension dominante de ce matériau. L'altérité apparaît seulement de manière indirecte, dans la mesure où le sujet se rapporte à lui-même comme à quelque chose qu'il observe. Il ne s'agit pas d'un autre humain, mais d'une forme de distance interne : le corps et les gestes sont regardés comme s'ils devenaient partiellement étrangers.

Ipséité

Indices cliniques : « je ne me reconnais plus entièrement » ; « sans y être vraiment présent » ; « il ne m'appartient plus tout à fait » ; « sentiment d'être dédoublé » ; « Je suis là, et en même temps à côté de moi » ; « C'est moi qui ne m'y reconnais plus ».

Organisation du vécu : L'ipséité est la dimension centrale de l'extrait. Le sujet continue à dire « je » et à vivre dans une continuité apparente, mais ce « je » ne coïncide plus pleinement avec ses gestes, son corps et sa présence. Le rapport à soi est marqué par une non-reconnaissance progressive : le sujet est encore là, mais il ne s'habite plus entièrement comme soi.

Mondanéité

Indices cliniques : « Les actes les plus simples prennent une étrangeté nouvelle » ; « Je continue à vivre comme avant » ; « Le temps n'est pas rompu ».

Organisation du vécu : Le monde quotidien n'est pas décrit comme objectivement bouleversé. Les actes simples, la continuité de la vie et l'écoulement du temps demeurent. Pourtant, ce monde familier est modifié par une étrangeté nouvelle. La mondanéité est donc organisée par une défamiliarisation du quotidien : le monde reste reconnaissable, mais il n'est plus habité avec la même évidence.

Éléments qui traversent plusieurs dimensions

- *La continuité apparente* : le sujet continue à agir, à vivre, à éprouver le temps comme normal.
- *La non-coïncidence avec soi* : les gestes, le corps, la présence et le monde familier deviennent partiellement étrangers.
- *L'étrangeté progressive* : ce qui était simple, familier et immédiat ne disparaît pas, mais perd son évidence.

Tableau synthétique : variante 1

Matériau clinique "brut"	Temporalité	Spatialité	Corporéité	Altérité	Ipséité	Mondanéité
« Depuis quelque temps »	Début d'une transformation progressive				Modification progressive du rapport à soi	
« Cette sensation ne vient pas brutalement »	Absence de rupture temporelle brutale				Continuité de soi encore maintenue malgré la transformation	
« Elle s'installe peu à peu »	Progression lente et graduelle				Altération graduelle du rapport à soi	
« Je continue à vivre comme avant »	Continuité apparente de la vie		Continuité des conduites et des actions		Décalage interne au sein d'une continuité maintenue	Monde ordinaire extérieurement stable
« Le temps n'est pas rompu. Il s'écoule normalement »	Continuité temporelle ; temps non désorganisé				Difficulté à se reconnaître dans cette continuité	Monde non désorganisé et reconnaissable
« Je ne me reconnais plus entièrement dans mes gestes »			Gestes accomplis mais non reconnus comme pleinement siens		Non-reconnaissance de soi dans ses propres actes	Actes familiers devenus moins évidents
« Je les accomplis »	Continuité des actes		Corps encore fonctionnel et engagé dans l'action		Maintien d'une capacité d'agir	Vie ordinaire maintenue
« sans y être vraiment présent »			Présence corporelle diminuée dans l'action		Présence diminuée à soi ; non-coïncidence avec ses actes	Vie ordinaire subjectivement altérée
« Mon corps me répond »			Corps fonctionnel, capable d'accomplir les gestes ordinaires		Maintien d'un lien avec son propre corps	
« il ne m'appartient plus tout à fait »			Corps partiellement étranger		Perte partielle d'appropriation	

					corporelle	
« Je le regarde fonctionner »		Distance intérieure ; position extérieure d'observateur	Corps observé comme s'il était extérieur	Rapport à soi-même comme à une réalité distincte	Position de spectateur de soi	
« avec une attention inquiète »			Vigilance portée au fonctionnement du corps		Inquiétude de soi à soi	Monde corporel devenu incertain
« Les actes les plus simples prennent une étrangeté nouvelle »	Apparition progressive d'une modification du quotidien		Gestes ordinaires altérés dans leur familiarité		Difficulté à se reconnaître dans les actes familiers	Monde quotidien défamiliarisé
« sentiment d'être dédoublé »		Distance interne entre deux positions subjectives		Altérité interne ; soi éprouvé comme partiellement autre	Dédoublement de soi	
« Je suis là, et en même temps à côté de moi »	Simultanéité de deux modalités de présence	Distance à soi ; position à côté de soi-même	Présence corporelle décalée	Rapport à soi sous la forme d'une altérité interne	Présence divisée ; non-coïncidence avec soi	
« C'est moi qui ne m'y reconnais plus »	Difficulté à se reconnaître dans la continuité temporelle		Non-reconnaissance dans le corps et les gestes		Ipséité fragilisée ; le sujet continue à dire « je », mais ne coïncide plus pleinement avec lui-même	Monde stable, mais subjectivement devenu étrange

Tableau synthétique : variante 2

Dimension	Indices cliniques du texte	Organisation du vécu
Temporalité	« Depuis quelque temps » : installation progressive. « Je les accomplis, mais sans y être vraiment présent » : continuité des actes. « Cette sensation ne vient pas brutalement » : absence de rupture soudaine. « Elle s'installe peu à peu » : progression lente. « Je continue à vivre comme avant » : continuité apparente. « Le temps n'est pas rompu. Il s'écoule normalement » : continuité temporelle.	Le temps demeure continu et n'est pas vécu comme rompu ou désorganisé. Les actes et la vie quotidienne se poursuivent apparemment comme auparavant. Toutefois, une transformation lente et progressive s'installe à l'intérieur de cette continuité. Le vécu temporel est donc marqué par une tension entre la permanence du cours de la vie et la modification graduelle du rapport à soi.
Spatialité	« Je le regarde fonctionner » : distance à soi. « Je suis là, et en même temps à côté de moi » : distance à soi et décalage par rapport à sa propre présence.	La spatialité ne renvoie pas ici à un espace physique extérieur, mais à une distance intérieure. Le sujet se vit à la fois présent et situé « à côté » de lui-même. Il occupe une position de retrait ou d'observation par rapport à son propre corps et à ses gestes. L'espace vécu est ainsi organisé par une non-coïncidence entre le lieu où le sujet se trouve et la manière dont il éprouve sa propre présence.
Corporéité	« Je ne me reconnais plus entièrement dans mes gestes » : gestes accomplis mais non reconnus. « Je les accomplis, mais sans y être vraiment présent » : corps engagé dans l'action. « Mon corps me répond, mais il ne m'appartient plus tout à fait » : corps fonctionnel mais partiellement étranger. « Je le regarde fonctionner » : corps observé comme extérieur. « Avec une attention inquiète » : vigilance corporelle. « Les actes les plus simples prennent une étrangeté nouvelle » : gestes ordinaires altérés. « Je continue à vivre comme avant » : continuité des conduites. « Je suis là, et en même temps à côté de moi » : présence corporelle décalée.	Le corps reste fonctionnel, répond aux intentions et permet la poursuite des conduites ordinaires. Toutefois, les gestes ne sont plus immédiatement reconnus comme pleinement siens. Le sujet observe son corps fonctionner comme s'il lui était partiellement extérieur. Cette mise à distance s'accompagne d'une vigilance inquiète et d'un sentiment d'étrangeté touchant même les actes les plus simples. La corporéité est ainsi organisée par une tension entre fonctionnement corporel conservé et perte du sentiment d'appropriation.
Altérité	Aucune figure d'autrui n'est directement présente dans le texte. « Je le regarde fonctionner » : le sujet adopte une position d'observateur à l'égard de lui-même. « Sentiment d'être dédoublé » : apparition d'une forme d'altérité interne. « Je suis là, et en même temps à côté de moi » : séparation de soi à soi.	Le rapport à autrui n'est pas directement décrit. L'altérité apparaît principalement sous une forme interne : le sujet se rapporte à son corps, à ses gestes et à sa propre présence comme à quelque chose de partiellement distinct. Il devient en quelque sorte le spectateur de lui-même. Cette altérité interne ne correspond pas à la présence d'un autre individu, mais à une distance de soi à soi produite par le dédoublement du vécu.
Ipséité	« Depuis quelque temps » : modification progressive du rapport à soi. « Je ne me reconnais plus entièrement dans mes gestes » : non-reconnaissance de soi. « Je les accomplis, mais sans y être vraiment présent » : présence diminuée à soi. « Mon corps me répond, mais il ne m'appartient plus tout à fait » : perte d'appropriation.	L'ipséité constitue la dimension centrale du vécu. Le sujet conserve la continuité de son existence, de ses actions et de sa conscience, mais il ne se reconnaît plus pleinement dans ce qu'il fait ni dans le corps qui agit. Il continue à dire « je », tout en adoptant une position de spectateur à l'égard de lui-même. Le sentiment d'être soi est fragilisé par une

Étape 3 — Tension structurante

Nom de la tension

Continuité apparente / non-coïncidence avec soi

La tension traverse :

- le rapport au temps
- le rapport au corps
- le rapport à soi
- le rapport au monde
- plus indirectement, le rapport à l'espace vécu

Polarité 1 : continuité apparente

Le sujet continue à vivre « comme avant ». Son corps répond encore. Les gestes sont accomplis. Le temps n'est pas rompu et s'écoule normalement. Les actes les plus simples sont encore possibles.

Cette première polarité indique que l'expérience n'est pas déterminée par une désorganisation massive ou une rupture immédiate. Quelque chose continue à fonctionner.

Polarité 2 : non-coïncidence avec soi

Dans cette continuité, le sujet ne se reconnaît plus entièrement. Il accomplit des gestes « sans y être vraiment présent ». Son corps lui répond, mais « ne [lui] appartient plus tout à fait ». Il se décrit comme « là » et en même temps « à côté » de lui-même.

Cette seconde polarité indique que la continuité de la vie ordinaire ne suffit plus à assurer le sentiment d'être soi. Le sujet reste présent, mais il ne coïncide plus pleinement avec ses gestes, son corps et sa propre présence.

Ce que cette tension permet

Cette tension permet le maintien d'une vie ordinaire. Le sujet continue à agir, à percevoir, à se déplacer dans le temps et à accomplir les gestes simples du quotidien. Il n'y a pas d'interruption brutale de l'existence ni d'effondrement manifeste de l'action.

Elle permet aussi une forme d'observation de soi : le sujet peut décrire ce qui lui arrive, repérer la modification progressive de son vécu et nommer le décalage qu'il éprouve.

Ce qu'elle limite

Cette tension limite la possibilité d'habiter pleinement ses gestes, son corps et sa présence.

Le sujet ne peut plus s'appuyer sur l'évidence habituelle d'être soi dans ce qu'il fait. Les actes simples deviennent étranges, le corps devient partiellement non approprié, et le monde familier perd son caractère immédiatement habitable.

Dimensions concernées

- le rapport au corps : le corps fonctionne, mais il ne semble plus pleinement approprié ;
- le rapport à soi : le sujet est présent, mais ne se reconnaît plus entièrement ;
- le rapport au monde : le quotidien demeure, mais il prend une étrangeté nouvelle ;

- le rapport au temps : le temps continue normalement, mais une transformation progressive s'y installe.

Étape 4 — Structure de vécu (formulation synthétique)

Le vécu semble organisé autour d'une tension entre continuité apparente et non-coïncidence avec soi. Le sujet continue à vivre comme avant : le temps s'écoule normalement, le corps répond, les gestes sont accomplis. Pourtant, cette continuité ne garantit plus le sentiment d'habiter pleinement son expérience.

Cette organisation apparaît principalement dans le rapport au corps et à soi. Le corps reste fonctionnel, mais il devient partiellement étranger : il répond sans être vécu comme entièrement approprié. Les gestes les plus simples continuent, mais ils prennent une étrangeté nouvelle. Le sujet n'est pas absent de ce qu'il vit ; il est au contraire attentif à ce qui se passe, mais cette attention prend la forme d'une inquiétude et d'une distance à soi.

Le monde quotidien reste reconnaissable : il n'est pas décrit comme rompu ou désorganisé. Mais il n'est plus habité avec la même évidence. Ce qui se modifie n'est pas d'abord le monde lui-même, mais la manière dont le sujet s'y reconnaît. L'ensemble dessine une manière d'exister marquée par une présence dédoublée : le sujet demeure là, continue à agir et à vivre, mais ne se sent plus pleinement coïncider avec son corps, ses gestes et son expérience.

Cette structure s'appuie sur les éléments suivants du texte :

- « je ne me reconnais plus entièrement dans mes gestes »
- « Je les accomplis, mais sans y être vraiment présent »
- « Mon corps me répond, mais il ne m'appartient plus tout à fait »
- « Les actes les plus simples prennent une étrangeté nouvelle »
- « Je continue à vivre comme avant, mais avec le sentiment d'être dédoublé »
- « Je suis là, et en même temps à côté de moi »
- « Le temps n'est pas rompu. Il s'écoule normalement »
- « C'est moi qui ne m'y reconnais plus »

Vérification finale

L'analyse reste ancrée dans le texte : les formulations s'appuient sur des expressions précises de l'extrait. Elle ne commence pas par un diagnostic : elle décrit d'abord la forme du vécu.

Elle distingue correctement :

- la description : indices du texte
- l'organisation : temporalité, corporéité, ipséité, mondanéité
- la tension : continuité apparente / non-coïncidence avec soi
- la structure : présence dédoublée dans une vie ordinaire maintenue
- elle retient les dimensions réellement soutenues par le matériau
 - . l'ipséité et la corporéité sont centrales
 - . la temporalité et la mondanéité sont importantes
 - . la spatialité est présente de manière indirecte
 - . l'altérité n'est pas dominante.
- elle formule une tension plutôt qu'un simple thème :

- . le thème pourrait être « *l'étrangeté à soi* »
- . mais la tension structurante est plus précise : *la vie continue, tandis que le sujet ne coïncide plus pleinement avec lui-même.*
- elle indique ce que cette organisation permet : le maintien d'une continuité ordinaire et d'une capacité de description de soi.
- elle indique ce qu'elle limite : l'appropriation du corps, des gestes et du monde familier.

Observations

1. Mme L., 42 ans

Mme L., 42 ans, entre dans le bureau de consultation. Elle s'assoit au bord de la chaise, sans s'adosser. Ses mains restent posées sur ses genoux, immobiles. Elle regarde par la fenêtre plus qu'elle ne regarde le clinicien. Son débit de parole est lent, avec de longs silences entre les phrases. Quand on lui pose une question, elle répond après plusieurs secondes, comme si elle devait franchir une distance pour revenir dans l'échange.

2. « *Matin sans forme* »

« Le matin, je reste longtemps dans mon lit. Je ne dors plus vraiment, mais je ne me lève pas non plus. Je regarde mon téléphone, je fais défiler des choses sans trop les voir. »
« Parfois je me dis que je devrais me lever, mais ça reste comme une idée un peu lointaine. Quand je finis par me lever, j'ai l'impression que la journée est déjà entamée sans moi. »

3. Madeleine, 50 ans

Madeleine, 50 ans, infirmière depuis de nombreuses années, arrive au rendez-vous avec une tenue soignée mais un visage marqué. Elle s'assoit lentement et reste quelques instants silencieuse avant de parler. Elle décrit ses journées comme très chargées, enchaînant les soins, les demandes des patients, les échanges avec les familles et les consignes de l'équipe. Elle dit avoir longtemps aimé ce rythme, se sentir utile et investie dans son travail.

Depuis quelque temps, elle évoque une difficulté croissante à se lever le matin, avec l'impression d'aborder la journée comme une suite d'actions à accomplir plutôt que comme un engagement. Elle parle de situations qui, auparavant, la touchaient, mais qui aujourd'hui la laissent indifférente ou distante. Elle dit continuer à faire ce qu'il faut, mais « sans y être vraiment ».

Le soir, elle décrit une sensation de vide, restant parfois assise sans rien faire, comme si tout effort supplémentaire était devenu impossible.

4. Mr. D.

Lors de l'entretien, M. D. s'assoit près de la porte et garde son manteau. Il regarde régulièrement vers le couloir quand quelqu'un passe.

Il parle à voix basse, et explique qu'il préfère ne pas trop parler au téléphone, « on ne sait jamais qui peut écouter ». Il dit aussi qu'il fait attention à ce qu'il écrit dans ses messages.

Depuis quelque temps, il a remarqué que certaines personnes dans la rue le regardent « un peu trop longtemps ». « Peut-être que je me trompe », ajoute-t-il, « mais on finit par voir des choses quand on fait attention ».

5. « *À distance des autres* »

Le patient passe l'essentiel de ses journées seul à son domicile. Il consacre du temps à des activités individuelles, comme lire ou utiliser son ordinateur, qu'il décrit comme suffisantes pour occuper sa journée.

Lorsqu'il évoque ses relations, il mentionne avoir peu de contacts et ne pas ressentir le besoin d'en développer davantage. Les interactions sociales sont rares et généralement limitées à des échanges fonctionnels.

Il indique se sentir à l'aise dans ce mode de vie et ne rapporte pas de difficulté particulière liée à cette organisation.

6. « Vérifier, remettre en ordre »

La patiente décrit un ensemble de conduites de vérification répétées avant de quitter son domicile : contrôle des fenêtres et de la porte, effectués à plusieurs reprises malgré une première vérification. Ces gestes peuvent prolonger le moment du départ et entraîner des retards.

Au cours de la journée, elle organise ses affaires selon un ordre précis. Lorsqu'un objet n'est pas placé comme prévu, elle signale une gêne et interrompt son activité pour le remettre à sa place.

Elle rapporte que ces conduites lui procurent un apaisement lorsqu'elles sont réalisées conformément à ce qu'elle attend.

7. « La salle de cours »

« Quand j'arrive en amphi, je m'installe toujours au fond. Comme ça je peux partir discrètement si besoin.

Je regarde les autres parler entre eux, mais je ne me sens pas vraiment à ma place.

J'écoute le cours, mais je ne prends pas beaucoup de notes. J'attends surtout que ça se termine. »

8. « Quand je commence quelque chose de nouveau... »

« Quand je commence quelque chose de nouveau, je suis très motivé, j'ai plein d'idées, j'y pense tout le temps.

Mais au bout de quelques jours, je me sens débordé, comme si ça devenait trop.

Alors je ralentis, je fais moins, puis je laisse tomber.

Et après, je m'en veux un peu, parce que j'aurais aimé continuer. »

9. Camille

Camille arrive en s'excusant d'un léger retard, parle rapidement, sourit et cherche régulièrement le regard du clinicien. Elle dit : « *Je ne sais pas trop si j'ai un problème... ça dépend des moments.* »

Elle décrit son travail : « *Quand il y a un projet, je m'implique à fond, je parle beaucoup, j'ai plein d'idées... et puis parfois, au moindre retour un peu froid, je me sens de trop. Alors je me mets en retrait... mais j'aimerais qu'on me relance.* »

À propos de ses relations : « *J'aime être avec les autres, sinon je m'ennuie. Mais avec eux, j'ai l'impression de devoir être intéressante... sinon je deviens invisible.* »

Elle ajoute : « *Quand on ne me regarde pas, j'ai l'impression de disparaître un peu.* »

Elle évoque ses relations amoureuses comme « *très intenses au début* », puis « *plus floues ensuite* ».

Ses journées alternent entre des périodes « *très actives, avec plein d'énergie* », et d'autres où « *tout retombe* » et où elle « *attend que quelque chose se passe* »

10. « Décisions impossibles »

« J'ai du mal à prendre des décisions. Même pour des choses simples, je repousse. »

« J'ai toujours l'impression que je pourrais me tromper, ou regretter. »

Du coup je laisse passer le temps, et parfois la décision se prend sans moi. Après, j'ai l'impression de ne pas vraiment choisir ma vie. »

11. M. V., 28 ans

M. V., 28 ans, participe à certaines activités collectives et se rend aux rendez-vous prévus. Il est présent physiquement, répond aux sollicitations et peut décrire ce qui s'est déroulé, mais rapporte par moments une impression de ne pas être vraiment impliqué dans ce qu'il vit.

Au cours des échanges, il indique avoir parfois l'impression d'observer la situation « comme de l'extérieur », avec une distance par rapport à ce qui se passe et à ce qu'il dit lui-même.

Dans son quotidien, il privilégie des activités solitaires et très organisées. Il mentionne que ces moments lui permettent de se sentir plus « rassemblé » et de réduire ces impressions de décalage.

12. Mme X.

Madame X. reçoit régulièrement des proches chez elle et veille à ce que tout soit prêt : rangement, organisation de l'espace, préparation des repas. Elle anticipe les besoins des autres et ajuste en permanence ce qui se passe pour que les échanges se déroulent sans accroc.

Au cours de ces moments, elle participe aux conversations, mais surveille en même temps l'ensemble de la situation : niveau sonore, circulation dans les pièces, déroulement des activités. Elle décrit rester attentive à tout ce qui pourrait nécessiter une intervention de sa part.

Après ces rencontres, elle rapporte une fatigue importante et le besoin de retrouver un espace calme, tout en évoquant sa satisfaction d'avoir « bien reçu » ses invités.

13. M. R., 28 ans

M. R. arrive quelques minutes en avance et reste debout dans la salle d'attente malgré les sièges disponibles. Dans le bureau, il change plusieurs fois de position, comme s'il cherchait une posture confortable sans y parvenir. Il parle avec un débit irrégulier, commence parfois une réponse puis s'interrompt pour reformuler : « ce n'est pas exactement ça ». Il décrit ses journées comme « remplies », mais dit passer d'une chose à une autre sans vraiment s'y arrêter. Il préfère « garder plusieurs options ouvertes » et évoque une difficulté à « choisir vraiment ».

14. La veste dans l'entrée

Depuis le décès de son compagnon, Mme R. n'a pas déplacé la veste restée suspendue dans l'entrée. Elle dit qu'elle ne la regarde pas vraiment, mais qu'elle sait qu'elle est là. Le matin, en sortant, elle ralentit souvent devant le porte-manteau. Elle continue à aller travailler et à voir ses proches, mais décrit son appartement comme 'trop calme',

surtout le soir. Elle dit : « Je fais les choses, mais il y a une partie de la journée qui reste derrière moi ».

15. Dans le vestiaire

Au club de sport, Clara évite de se changer quand les autres sont présentes. Elle arrive souvent déjà en tenue et repart rapidement après la séance. Elle dit aimer l'activité elle-même, mais redouter le moment du vestiaire : 'J'ai l'impression que mon corps prend toute la place.' Pendant la séance, elle se place plutôt en bout de rang et vérifie régulièrement si quelqu'un la regarde.

16. Trop de bruit

Dans les lieux très fréquentés, Sami dit se sentir rapidement « envahi ». Les conversations se mélangent, les lumières lui paraissent trop fortes, les mouvements autour de lui deviennent difficiles à suivre. Il ne panique pas, mais cherche rapidement un mur, une sortie ou un endroit plus calme. Après ces moments, il se sent épuisé et a besoin de rester seul.

17. Le message non envoyé

Inès écrit souvent des messages qu'elle n'envoie pas. Elle les relit plusieurs fois, change un mot, puis ferme l'application. Elle dit qu'elle voudrait répondre simplement, mais que chaque phrase lui paraît trop visible. Plus le temps passe, plus le message devient difficile à envoyer. Elle finit parfois par ne plus répondre du tout, puis se reproche ce silence.

18. Une journée cadrée

Depuis plusieurs mois, Paul organise ses journées de manière très précise. Il ne décrit pas cela comme une contrainte, mais dit que lorsque l'ordre prévu est modifié, il se sent 'désaccordé'. Il peut continuer ce qu'il fait, mais avec une impression de flottement. Les moments imprévus lui demandent un effort particulier, comme s'il fallait reconstruire la journée à partir de zéro.

19. Le quai

Depuis quelques semaines, Nora arrive souvent en avance à la gare, mais laisse passer plusieurs trains avant de monter. Elle dit qu'elle sait où elle doit aller, mais qu'au moment d'entrer dans le wagon, « quelque chose reste en arrière ». Elle regarde les autres monter, puis attend le train suivant. Lorsqu'elle finit par partir, elle a l'impression que la journée a déjà commencé sans elle.

20. La table préparée

Avant de recevoir ses amis, Karim vérifie longuement la disposition de la table, l'ordre des chaises et le déroulement prévu de la soirée. Pendant le repas, il participe aux échanges, mais garde une attention constante à ce qui pourrait manquer ou se dérégler. Après le départ des invités, il se dit satisfait, mais épuisé, comme s'il avait surtout « tenu la soirée ».

21. La réponse attendue

Élise consulte régulièrement son téléphone après avoir envoyé un message. Elle ne sait pas exactement ce qu'elle attend, mais dit que tant que la réponse n'arrive pas, elle reste « suspendue ». Elle peut continuer ses activités, mais avec une partie de son attention retenue ailleurs. Quand la réponse arrive, elle se sent soulagée quelques instants, puis relit les mots pour vérifier ce qu'ils signifient.

22. La pièce trop pleine

Lors des réunions, Lucas choisit une place proche du mur. Il dit que ce n'est pas la discussion qui le gêne, mais la quantité de choses à suivre en même temps : voix, mouvements, regards, déplacements. Plus la réunion avance, plus il a besoin de réduire son attention à un seul point de la pièce. En sortant, il décrit une fatigue « dans tout le corps ».

23. Le dimanche immobile

Le dimanche, Anaïs garde souvent les volets à moitié fermés. Elle dit qu'elle n'est pas triste, mais que la journée « n'appelle à rien ». Elle prépare parfois du café, range un peu, puis s'assoit longuement sans décider de la suite. Le soir venu, elle a l'impression que la journée s'est écoulée sans véritable forme.

24. La lumière du supermarché

Au supermarché, Mina avance lentement dans les rayons, liste à la main. Elle sait ce qu'elle est venue acheter, mais les lumières, les annonces sonores et les déplacements des autres clients rendent chaque choix plus difficile. Elle s'arrête souvent devant les produits sans parvenir à décider. En sortant, elle dit avoir l'impression d'avoir « tenu bon », mais se sent vidée, comme si une simple course avait occupé toute sa journée.

25. « Avant d'ouvrir la messagerie »

Depuis plusieurs mois, Sophie, 39 ans, travaille dans une équipe où son responsable commente régulièrement son travail devant ses collègues. Il lui arrive de reprendre ses erreurs en réunion, de lui confier des tâches dans des délais très courts ou de lui envoyer des messages tard le soir en demandant une réponse rapide. Sophie dit qu'elle ne sait jamais « sur quel ton la journée va commencer ».

Le matin, avant d'allumer son ordinateur, elle reste parfois plusieurs minutes immobile devant son bureau. Elle vérifie sa messagerie sans ouvrir immédiatement les nouveaux messages. Lorsqu'elle voit le nom de son responsable apparaître, elle ressent une tension dans la poitrine et relit plusieurs fois le contenu avant de répondre, de peur qu'une phrase puisse être mal comprise ou utilisée contre elle.

Au travail, elle parle moins qu'auparavant et évite de proposer de nouvelles idées. Pendant les réunions, elle choisit une place en retrait et observe attentivement les réactions de son responsable. Elle prépare ses interventions à l'avance, mais renonce souvent à prendre la parole. Elle dit : « Même quand il ne dit rien, j'attends que quelque chose tombe. »

Elle continue à accomplir ses tâches et reste parfois plus tard pour vérifier son travail. Pourtant, elle a de plus en plus l'impression de ne jamais faire correctement. Lorsqu'un

collègue lui adresse une remarque neutre, elle se demande immédiatement si une critique circule à son sujet.

Le soir, elle repense aux échanges de la journée et reconstruit mentalement les conversations, en cherchant ce qu'elle aurait dû dire autrement. Elle consulte encore sa messagerie professionnelle chez elle, bien qu'elle redoute d'y trouver un nouveau message. Elle décrit son domicile comme le seul endroit où elle peut « relâcher un peu », mais dit que le travail reste présent dans sa tête, même lorsqu'elle essaie de faire autre chose.

Depuis quelque temps, le dimanche soir lui paraît particulièrement lourd. Elle prépare ses affaires très tôt, dort difficilement et anticipe les situations possibles du lendemain. Elle dit : « Je sais que je dois y retourner, mais j'ai l'impression que toute la semaine est déjà devant moi. »

Textes (prose)

A. « À l'hôpital » - Henri Michaux (1935)

« À l'hôpital »

Mon mal est atroce.

L'on m'a donné une chambre un peu à l'écart dans l'hôpital.

Je la partage avec une tousseuse.

On s'attendait sans doute à ce que par les hurlements que m'arracherait bientôt la souffrance, je détruirai le sommeil de tous les malades de la grande salle.

Non !

Chaque matin j'examine mes forces d'une part, et les progrès de mon mal d'autre part, et je me décide tant à tenir encore aujourd'hui qu'à irrévocablement le lendemain me laisser aller aux hurlements de mon infernale souffrance que je ne puis plus retenir qu'avec une peine extrême dont le trop plein est imminent, imminent, s'il n'est déjà atteint.

Cependant, le lendemain je résiste encore à la pression grandissante et déjà bien au-delà de ce que je pensais pouvoir supporter.

Mais pourquoi, pourquoi donc m'a-t-on mis une tousseuse qui me dilacère mes rarissimes moments de paix et effiloche désastreusement le peu de continuité que j'arrive encore à garder en ce terrible harcèlement du mal ?

(Henri Michaux, *La nuit remue*, Paris, Gallimard, 1935).

B. Bartleby - Herman Melville (1853)

Il restait assis à son bureau, immobile, les yeux ouverts mais sans véritable regard.

Il exécutait son travail avec exactitude, sans hâte ni résistance. Lorsqu'on lui adressait la parole, il répondait calmement, sans émotion perceptible.

Peu à peu, il cessa d'entrer dans les échanges ordinaires. Il n'expliquait rien, ne protestait pas, ne justifiait pas ses décisions. À chaque demande nouvelle, il répétait simplement qu'il préférerait ne pas le faire.

Cette réponse n'avait rien d'agressif. Elle ne cherchait pas à convaincre. Elle ne s'adressait presque à personne.

Sa présence était constante, mais sans engagement. Il était là, physiquement, sans sembler participer au monde autour de lui. Le temps passait sans qu'il manifeste l'impatience ou l'ennui.

Rien ne paraissait le pousser à agir, mais rien non plus ne semblait le retenir. Il ne fuyait pas, il ne demandait rien.

C. La Nausée - Jean-Paul Sartre (1938)

Tout à coup, les choses se mirent à exister avec une intensité insupportable. Les objets n'étaient plus familiers. Ils perdaient leur usage, leur fonction, leur discrétion habituelle.

Je regardais une racine d'arbre, et elle cessait d'être une racine. Elle devenait une chose brute, sans justification. Le monde ne se présentait plus comme un ensemble organisé, mais comme une accumulation pesante de présences.

Mon corps participait à ce trop-plein. Je sentais son poids, sa lourdeur, son adhérence au sol.

Le temps n'apportait aucun apaisement. Chaque instant se donnait isolément, sans transition. Il n'y avait plus de continuité, seulement des surgissements.

Je n'étais pas angoissé au sens ordinaire. J'étais envahi.

D. Oblomov - Ivan Gontcharov (1859)

Oblomov restait allongé de longues heures, sans ressentir le besoin de se lever. Le temps s'écoulait sans le presser. Les minutes, les heures, les journées passaient avec la même consistance molle.

Il ne se disait pas que demain serait différent d'aujourd'hui.

Les pensées venaient à lui sans ordre. Il ne cherchait pas à les organiser ni à les retenir.

Il les laissait passer, comme on laisse passer un nuage.

Le monde extérieur ne l'attirait pas, mais ne l'effrayait pas non plus. Il semblait simplement sans urgence. Il ne se sentait pas malheureux. Il ne se sentait pas heureux non plus. Il était là, dans une continuité sans relief, où l'existence se maintenait sans tension, sans élan, sans rupture.

E. Les Liaisons dangereuses - Choderlos de Laclos (1782)

Je ne puis supporter votre silence. Lorsqu'il dure, il me semble que je cesse d'exister. Votre présence m'exalte, m'anime, me donne une intensité que je ne trouve nulle part ailleurs.

Mais cette intensité est instable. Elle se transforme rapidement en inquiétude.

Quand vous êtes trop proche, je crains de me perdre. Quand vous vous éloignez, je me sens vide, abandonnée à moi-même. Il n'y a pas de juste milieu.

Mon humeur dépend de vos gestes, de vos paroles, de leur absence. Le monde entier semble suspendu à la relation.

Je sais que cet état me fait souffrir, mais je ne peux m'en détacher.

F. Les Vagues - Virginia Woolf (1931)

Je ne me perçois pas comme un tout stable. Je suis faite de moments qui apparaissent et disparaissent.

Le temps ne s'écoule pas régulièrement. Il avance par vagues. Certains instants sont pleins, d'autres presque inexistantes.

Mon identité change selon ce que je ressens, selon la présence des autres, selon le rythme du monde. Il n'y a pas de centre fixe.

Je suis traversée par des impressions plus que par des pensées.

Le monde m'atteint par fragments. Je m'y adapte sans jamais m'y fixer complètement.

G. Mrs Dalloway - Virginia Woolf (1925)

Chaque détail du monde m'atteint avec force. Les bruits, les voix, les regards ont une intensité excessive.

Le passé surgit dans le présent sans prévenir. Une sensation suffit à me replonger ailleurs.

Je peux me sentir exaltée, pleinement vivante, puis soudain écrasée par une impression trop forte.

Le monde est tantôt vibrant, tantôt accablant. Je n'ai pas toujours la distance nécessaire pour m'y tenir.

Je continue pourtant à avancer, à agir, à paraître stable.

H. Les Âmes mortes - Nikolai Gogol (1842)

Il participait aux échanges sociaux sans y prendre goût. Les conversations lui semblaient longues, sans nécessité.

Il ne méprisait personne. Il ne se sentait simplement pas concerné.

Il répondait poliment, mais sans s'engager. Il préférait les moments de solitude, où rien ne lui était demandé.

Le monde social lui apparaissait comme un ensemble de conventions auxquelles il se pliait sans conviction.

Il n'y avait pas de conflit intérieur. Seulement un retrait tranquille, comme si l'existence pouvait se dérouler en marge.

I. Le Journal d'un fou - Nikolai Gogol (1835)

Les journées se ressemblent toutes. Je fais ce que j'ai à faire sans y penser vraiment.

Les émotions sont reconnaissables, mais lointaines.

Je me regarde agir comme on observe quelqu'un d'autre. Les gestes s'enchaînent mécaniquement.

Le monde ne m'atteint plus directement. Il glisse sur moi.

Je ne souffre pas. Je ne vais pas bien non plus.

J. Walden - Henry David Thoreau (1854)

La solitude ne m'opprime pas. Elle m'apaise. Le monde social me paraît souvent trop bruyant, trop rapide.

Seul, le temps ralentit. Chaque geste retrouve sa juste place.

Je n'éprouve pas le besoin constant des autres.

Le monde est plus lisible quand il n'est pas saturé de présences humaines.

Je me tiens à distance, non par peur, mais par choix. Cette distance me permet d'exister plus clairement.

Textes (haïkus)

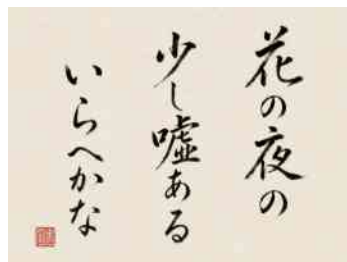
Mayuzumi Madoka, *Haïkus du temps présent*, Arles, Picquier poche, 2014.

« *Nuit de fleurs* »

Nuit de fleurs –
un petit mensonge
dans ma réponse

hana no yo no / sukoshi uso aru / irae kana

花の夜の
少し嘘ある
いらへかな

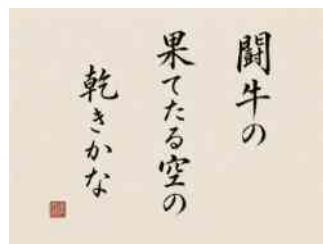


« *Le combat de taureaux terminé* »

Le combat de taureaux terminé
le ciel paraît
si sec

tôgyû no hatetaru sora no kawaki kana

闘牛の
果てたる空の
渇きかな

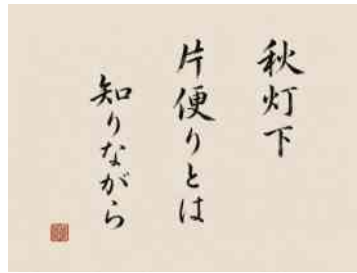


« *Sous la lampe d'automne* »

Sous la lampe d'automne
j'écris
sans espoir de réponse

shûtô-ka katadayori to wa shirinagara

秋灯下
片便りとは
知りながら

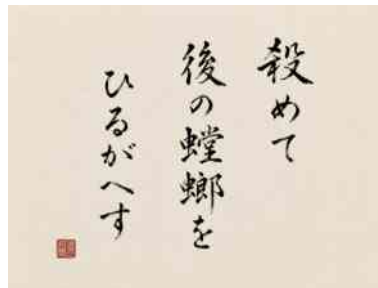


« *Je l'ai tuée* »

Je l'ai tuée
puis retournée
la mante religieuse

ayamete nochi no tôrô o hirugaesu

殺めて
後の螳螂を
ひるがへす

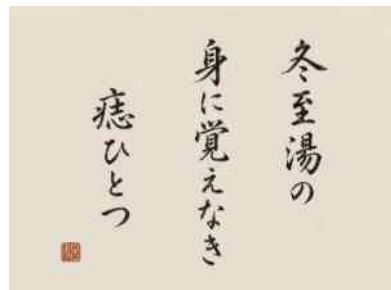


« *Bain du solstice d'hiver* »

Bain du solstice d'hiver –
sur mon corps la marque d'un coup
dont je n'ai pas souvenir

tôjiyu no mi ni oboe naki aza hitotsu

冬至湯の
身に覚えなき
痣ひとつ



Claire, 40 ans

Claire, 40 ans, se présente attentive mais tendue. Elle garde son sac serré sur ses genoux, avec des gestes précis et légèrement raides. Son regard se porte brièvement vers la porte et les fenêtres. Elle s'excuse d'être « sur ses gardes », surtout dans les lieux inconnus. Son attention demeure tournée vers l'environnement.

Depuis plusieurs années, elle éprouve une peur intense dans les gares, centres commerciaux, tunnels, parkings souterrains et trains. Elle décrit alors une montée de chaleur, un brouillard perceptif, des frémissements thoraciques, des picotements dans les mains, une tension de la nuque et l'impression que le sol devient moins sûr. Elle tente de contrôler sa respiration « comme si tout dépendait de ça » et cherche parfois un mur ou une rambarde.

Elle organise ses déplacements pour éviter la foule et les espaces clos, choisit des itinéraires extérieurs et repère systématiquement les issues. En réunion, elle s'assoit près d'une porte. Après ces situations, elle ressent un relâchement brutal et doit s'isoler. Elle vérifie aussi plusieurs fois portes, fenêtres ou plaques de cuisson, bien qu'elle sache les avoir sécurisées. Ces vérifications augmentent lorsqu'elle est fatiguée et peuvent la retarder.

Par périodes, Claire se sent « tassée », ralentie et sans élan pour sortir ou voir ses amis. Elle parle moins de tristesse que de lourdeur intérieure et préfère rester chez elle, où elle se sent « moins exposée ».

Elle rapporte un accident de voiture survenu à l'adolescence dans un tunnel, avec immobilisation prolongée, bruits métalliques et odeur de carburant. Certaines images reviennent dans les passages souterrains. À 26 ans, une altercation violente au travail l'avait laissée « figée ». Ces souvenirs peuvent resurgir dans les lieux clos ou bruyants. Lorsqu'elle les évoque, sa respiration se raccourcit, ses doigts se crispent et ses yeux s'humidifient.

Elle imagine parfois qu'elle ne pourra plus respirer dans un ascenseur ou qu'elle s'effondrera dans une file d'attente. Elle sait ces scénarios improbables, mais les éprouve comme de « petits films » difficiles à interrompre. Elle craint aussi de paraître étrange, vérifie son reflet et dissimule ses difficultés.

Ses évitements ont réduit ses sorties, ses déplacements et sa vie affective. Elle annule parfois au dernier moment et redoute d'être un poids pour autrui. Elle ne rapporte pas d'idées suicidaires, mais des épisodes cycliques de lassitude. Elle souhaite comprendre la persistance des images anciennes, retrouver une respiration normale et se déplacer sans devoir tout anticiper.

Clinique phénoménologique

Analyse existentielle

Temporalité

Spatialité

Corporéité

Altérité

Ipséité

Mondanéité

Tension structurante

Structure de vécu et formulation existentielle

Psychopathologie psychodynamique

Psychopathologie cognitive

Psychopathologie anthropo-phénoménologique

Psychopathologie neuro-phénoménologique

Hypothèses diagnostiques

Pierre, 27 ans

Pierre, 27 ans, se présente ponctuel, soigné et préoccupé. Sa voix devient hésitante ou précipitée selon les moments. Il repère brièvement les issues, regarde souvent son sac et s'excuse de « prendre du temps ».

Depuis plusieurs années, il vit avec une peur qui surgit dans les transports, les salles bondées et les lieux dont il ne peut sortir immédiatement. Il organise ses déplacements pour rester dehors, emporte de quoi se rassurer et évite ascenseurs, centres commerciaux et places centrales. Dans ces situations, il ressent une brusque « montée interne », l'impression que « tout se rétrécit », une modification de ses appuis et la crainte de ne plus tenir debout. Son attention se fixe alors sur les sorties.

Certaines nuits, il reste en alerte, comme si quelque chose allait arriver. Au réveil, il éprouve parfois une absence d'envie, reste chez lui et regarde son téléphone sans vraiment lire. Son récit revient souvent sur des détails sensoriels précis : bruit d'un néon, chaleur d'une file d'attente, place choisie dans un bus.

Des scénarios mentaux s'imposent à lui : s'effondrer, agir bizarrement ou attirer les regards. Il sait ces pensées excessives mais peine à les interrompre. Il vérifie aussi portes et appareils, malgré la certitude de les avoir sécurisés, et ne peut partir avant d'avoir recommencé.

Depuis un épisode de rougeur en classe, il surveille étroitement son apparence. Il contrôle son reflet, touche son visage, ajuste ses cheveux, sa barbe, son col ou sa manche. Il s'inquiète de son nez et de sa mâchoire, prend plusieurs photos par jour pour vérifier et reconnaît que ces gestes occupent trop de place.

Au travail, il évite les présentations, prépare excessivement ses interventions et garde un objet sur ses genoux comme limite rassurante. Les réunions le laissent épuisé. Il refuse aussi des sorties, préfère recevoir chez lui, relit plusieurs fois ses messages et redoute d'être jugé de près dans une relation affective.

Sa pensée demeure cohérente, sans trouble perceptif ni défiance. Elle se resserre cependant autour du malaise imminent, du regard d'autrui et des détails corporels. Par périodes, il décrit une fatigue intérieure, un ralentissement du monde, un retrait social et une indifférence passagère envers ses projets, sans idée suicidaire.

Pierre souhaite réduire les peurs, vérifications et préparations qui organisent son quotidien, retrouver de la spontanéité et ne plus vivre « en lutte permanente ». Il aimerait sortir sans anticiper constamment une possible issue.

Clinique phénoménologique

Analyse existentielle

Temporalité

Spatialité

Corporéité

Altérité

Ipséité

Mondanéité

Tension structurante

Structure de vécu et formulation existentielle

Psychopathologie psychodynamique

Psychopathologie cognitive

Psychopathologie anthropo-phénoménologique

Psychopathologie neuro-phénoménologique

Hypothèses diagnostiques

Jean, 50 ans

Jean, 50 ans, fils unique, est issu d'un milieu social très modeste et a grandi dans un climat familial conflictuel. Jean présente son père comme étant alcoolique et brutal, discrédité par sa mère, et garde le souvenir d'une mère très protectrice, possessive, envahissante. Elle l'a investi très tôt de responsabilités familiales tout en conservant une forte emprise sur lui. Dès son plus âge, il était respecté de tous, craint pour sa prestance et son orgueil. Après une scolarité brillante, il est devenu chef du personnel dans une entreprise prestigieuse. Il s'est marié à 30 ans avec une femme de 20 ans, dont la beauté le valorise et l'inquiète dans le même temps (il lui reproche d'être « trop séduisante »). Il apprécie sa souplesse de caractère et son dévouement à la famille mais en même temps il la critique à tous propos, lui adresse des moqueries humiliantes. Rapidement, ils ont trois enfants. De caractère froid et distant, il est devenu violent et suspicieux lorsque sa femme a repris son activité professionnelle à 38 ans. Meticuleux et perfectionniste, il aimait par dessus tout que son intérieur soit impeccable et il trouve déplacé que sa femme travaille à l'extérieur. Jean est en effet habitué à gérer son foyer et la scolarité de ses enfants, sans laisser à sa femme l'occasion d'exprimer ses propres idées. Au fil du temps, sa jalousie s'accroît, il suit sa femme, soupçonne qu'elle a un ou plusieurs amants et finit par lui interdire de sortir sans lui, et même de téléphoner. Craignant qu'elle ne s'en prenne à lui, il refuse de manger ce qu'elle lui prépare. De peur qu'elle ne s'échappe ou l'agresse dans son sommeil, il passe la nuit dans le salon, soucieux et silencieux, guettant le moindre bruit. Il est convaincu que sa femme se lève la nuit pour rejoindre ses amants ou communiquer avec eux par des signaux lumineux. Jean ne comprend pas le comportement de sa femme car il sait très bien que si elle le quitte, elle ne sera plus rien. Pensant avoir identifié un des amants de sa femme, un voisin de palier, il lui envoie des lettres d'insultes, et le menace par téléphone en pleine nuit. Il pense que ces enfants, manipulés par leur mère, protègent cette relation. Finalement, il se rend chez le voisin et le menace physiquement. Devant le danger potentiel que représente la conviction d'une relation entre sa femme et le voisin, celui-ci prévient le médecin traitant de Jean qui décide de le faire hospitaliser contre son gré. Jean ne se considère pas malade, il clame sa bonne foi et se raccroche à l'ensemble des preuves qu'il croit avoir réunies. Pendant son hospitalisation, un entretien avec le psychologue révèle que Jean se sentait parfois prêt à éclater en mille morceaux et que durant ses longues méditations nocturnes, il sentait la mort rôder autour de lui. Malgré un traitement médicamenteux et psychothérapeutique, Jean est toujours persuadé sans raison que sa femme le trompe.

Clinique phénoménologique

Analyse existentielle

Temporalité

Spatialité

Corporéité

Altérité

Ipséité

Mondanéité

Tension structurante

Structure de vécu et formulation existentielle

Psychopathologie psychodynamique

Psychopathologie cognitive

Psychopathologie anthropo-phénoménologique

Psychopathologie neuro-phénoménologique

Hypothèses diagnostiques

Monsieur D., 38 ans

Monsieur D., 38 ans, cadre dans la finance, consulte après plusieurs épisodes d'engourdissement des mains et une sensation d'étouffement au bureau.

Les examens médicaux n'ont rien révélé. Il explique calmement être venu « pour vérifier s'il y a quelque chose à modifier dans [son] mode de fonctionnement ».

Il ne rapporte aucune émotion particulière, dit n'avoir « jamais été quelqu'un qui se pose des questions », et décrit son quotidien de manière factuelle.

Il dit par exemple : « Je n'ai pas de problèmes majeurs. J'ai une vie normale. Je suis quelqu'un de stable. »

Lorsqu'on l'interroge sur ses relations proches, il répond : « Tout se passe bien, je n'ai pas de conflits. Ma femme me dit que je suis trop neutre, mais c'est son point de vue. »

Lorsque vous lui demandez ce qu'il a ressenti lors de ses épisodes d'engourdissement, il répond : « Je ne ressens rien de particulier. J'ai observé que ça arrivait plus souvent le mardi après-midi. »

Clinique phénoménologique

Analyse existentielle

Temporalité

Spatialité

Corporéité

Altérité

Ipséité

Mondanéité

Tension structurante

Structure de vécu et formulation existentielle

Psychopathologie psychodynamique

Psychopathologie cognitive

Psychopathologie anthropo-phénoménologique

Psychopathologie neuro-phénoménologique

Hypothèses diagnostiques

Mme R., 35 ans

Mme R., 35 ans, arrive légèrement en retard, soignée et très contrôlée dans sa posture. Elle ajuste sa tenue, observe brièvement le cadre et adresse au clinicien un sourire maîtrisé. Son discours est fluide, précis, soigneusement construit, avec de fréquentes reformulations lorsque l'émotion affleure.

Elle décrit une semaine « intense » et insiste sur sa capacité à soutenir un rythme élevé. Une réunion récente l'a particulièrement affectée : un collègue plus jeune y a présenté un projet relevant selon elle de son domaine d'expertise. Elle parle d'une « impression de décalage » et décrit avec minutie les regards et l'attention accordée à chacun. Son visage se tend lorsqu'elle évoque la scène. Le soir, elle relit inutilement des documents et rejoue mentalement la réunion, au prix d'un endormissement difficile.

Dans sa vie relationnelle, elle se montre très sensible aux signes de considération. Une remarque de son compagnon l'invitant à relativiser est vécue comme une absence d'écoute. Lors d'un dîner, l'attention portée par une amie à un autre invité lui donne une impression d'effacement. Elle redouble alors de vivacité pour reprendre sa place, tout en se sentant intérieurement en retrait.

Mme R. minimise rarement ses affects de façon directe. Elle transforme rapidement toute émotion en explication, nuance ou justification. Un reproche professionnel ne l'aurait pas « dévastée », mais seulement « intriguée ». Elle parle peu de vulnérabilité et utilise des formulations atténuées, tandis que son expression corporelle laisse apparaître davantage de tension.

Son histoire est marquée par la réussite, les compliments et l'exigence familiale. Elle cherchait à impressionner un père exigeant et à maintenir une image valorisante pour sa famille. Elle dit aujourd'hui que, si cette image se fissure, « tout pourrait se défaire ». Certains jours, elle se sent à la hauteur ; d'autres, dispersée, fragile ou insuffisamment reconnue.

Après le travail, elle peut rester immobile dans l'obscurité, sans direction, ou au contraire rouvrir des dossiers et réorganiser son appartement. Elle rapporte tensions cervicales, migraines, chaleur soudaine, sommeil agité et réveils nocturnes. Son avenir alterne entre ambition assurée et crainte d'un épuisement ou d'une perte de reconnaissance.

Dans l'entretien, elle se détend lorsqu'elle se sent valorisée, mais se redresse et reprend le contrôle face à un silence ou une nuance ambiguë. À la fin, elle réajuste soigneusement son apparence et vérifie le regard du clinicien, comme pour s'assurer de l'image laissée avant de quitter la pièce.

Clinique phénoménologique

Analyse existentielle

Temporalité

Spatialité

Corporéité

Altérité

Ipséité

Mondanéité

Tension structurante

Structure de vécu et formulation existentielle

Psychopathologie psychodynamique

Psychopathologie cognitive

Psychopathologie anthropo-phénoménologique

Psychopathologie neuro-phénoménologique

Hypothèses diagnostiques

Monsieur L., 27 ans

M. L., 27 ans, se présente sur recommandation de son médecin. Son attitude est polie et très contrôlée, mais son regard hésite entre contact et évitement. Assis, il croise et décroise les jambes, serre puis relâche le tissu de son pantalon. Il dit que « tout se complique » et qu'il ne sait plus toujours ce qui est raisonnable.

Son enfance est évoquée de manière fragmentée. Son père lui apparaissait imprévisible, capable de réagir sévèrement à une remarque anodine puis d'ignorer un problème manifeste. Sa mère était attentive, mais lui semblait manquer ce qu'il éprouvait réellement. Certains souvenirs sont très précis, tandis que des périodes entières restent « brumeuses », comme s'il avait vécu « en arrière-plan ».

À l'école puis au travail, il alterne investissement intense et désengagement brutal. Il commence ses projets avec enthousiasme, travaille sans fatigue apparente, puis perd soudain tout élan. Ses emplois se terminent souvent après des tensions relationnelles ou une lassitude profonde.

Ses relations amicales et amoureuses deviennent rapidement très proches. Cette proximité lui donne le sentiment d'exister pleinement, mais un silence, un message sans réponse ou une expression ambiguë peuvent provoquer un doute envahissant. Il prend alors ses distances, puis considère le retour impossible. Il oscille entre peur d'être abandonné et crainte d'être trop exposé ou sollicité.

En séance, il peut être engagé dans l'échange, puis se sentir soudain « ailleurs ». Son regard se détourne, son ton s'aplatit et l'émotion semble s'effacer. Lors de tensions, il rapporte un resserrement thoracique, une impression de menace, des réactions verbales vives, puis de la honte, de l'agitation ou du vide. Le lendemain, l'événement peut lui sembler presque sans lien avec son présent.

Il décrit aussi des images mentales rapides, parfois violentes, qu'il distingue de la réalité. Son activité fluctue entre projets multiples, sommeil réduit et décisions impulsives, puis retrait prolongé, perte d'élan et heures passées au lit. Il envoie parfois des messages nocturnes, engage des dépenses ou prend des décisions radicales, avant de se replier.

Son image de lui-même varie fortement : capable de grandes choses certains jours, il se sent sans consistance d'autres fois. La solitude est tour à tour recherchée et redoutée. Il sollicite intensément l'aide, puis minimise ses difficultés ou refuse de « creuser ». Il souhaite disposer d'un lieu où « mettre de l'ordre », tout en craignant ce que l'exploration pourrait faire émerger dans son expérience.

QCM 1

Consigne : pour chaque question, sélectionnez la ou les propositions exactes.

Observation 1 – Emma

Emma, 22 ans, consulte après plusieurs mois de difficultés à reprendre les cours. Elle explique :

« Je me lève, mais je reste longtemps assise sur mon lit. Je sais que je devrais y aller, mais je n'arrive pas à sortir. Les journées passent toutes pareil. Je regarde l'heure, puis je me dis que c'est trop tard. Alors je reste chez moi. »

Elle ajoute : « À la fac, j'ai l'impression que tout le monde avance. Moi, je suis là, au même point. Quand je croise des gens de ma promo, je souris, mais j'ai envie de disparaître. Je ne sais même plus vraiment ce que je fais là. »

Question 1 : *Quelle formulation respecte le mieux la posture phénoménologique initiale ?*

- A. Emma présente probablement un trouble anxieux avec évitement social.
- B. Emma manque de volonté pour reprendre les cours.
- C. Le vécu d'Emma semble marqué par une difficulté à passer à l'action et par un temps répétitif.
- D. Emma refuse inconsciemment de devenir adulte.

Question 2 : *Quels éléments constituent des indices du vécu brut ?*

- A. « Je reste longtemps assise sur mon lit. »
- B. « Elle a une phobie sociale. »
- C. « Les journées passent toutes pareil. »
- D. « Elle évite la fac parce qu'elle a peur d'échouer. »

Question 3 : *Quelle dimension du vécu est particulièrement présente dans l'expression : « Les journées passent toutes pareil » ?*

- A. Temporalité
- B. Spatialité
- C. Corporéité
- D. Altérité

Question 4 : *Quelle formulation relève d'une interprétation psychologique prématurée ?*

- A. Le temps apparaît répétitif.
- B. Emma reste longtemps assise sur son lit.
- C. Emma cherche à attirer l'attention par son retrait.
- D. L'espace universitaire semble difficile à habiter.

Question 5 : *Dans l'observation 1, quels indices peuvent être rattachés à la spatialité ?*

- A. « Je n'arrive pas à sortir. »
- B. « Alors je reste chez moi. »
- C. « Je regarde l'heure. »
- D. « À la fac, j'ai l'impression que tout le monde avance. »

Question 6 : *Quelle formulation décrit correctement le rapport au corps d'Emma ?*

- A. Le corps est peu mobilisé dans l'action.
- B. Le corps est engagé dans une forte activité motrice.
- C. La posture assise prolongée peut être décrite comme un indice de retenue ou d'immobilisation.
- D. Emma somatise son conflit psychique.

Question 7 : *Quelle tension structurante paraît la plus pertinente pour l'observation 1 ?*

- A. Action possible / impossibilité de passer à l'action
- B. Intelligence / manque d'intelligence
- C. Extraversion / introversion
- D. Présence au monde universitaire / retrait du monde universitaire

Question 8 : *Quelle formulation correspond le mieux à une structure de vécu ?*

- A. Emma est anxieuse et démotivée.
- B. Emma souffre d'un trouble anxieux qui explique son évitement.
- C. Le vécu d'Emma semble organisé autour d'une tension entre l'appel du monde universitaire et l'impossibilité de s'y engager. Cette organisation permet de préserver une forme de retrait protecteur, mais limite l'action, la projection et le sentiment d'avoir une place.
- D. Emma a peur de réussir et préfère rester chez elle.

Question 9 : *Dans l'expression « j'ai envie de disparaître », quelle dimension est particulièrement sollicitée ?*

- A. Altérité, car la présence des autres est vécue comme exposante.
- B. Ipséité, car le sentiment d'être soi et d'avoir une place semble fragilisé.
- C. Temporalité, car le passé est explicitement idéalisé.
- D. Corporéité, si l'on considère la manière dont le corps semble vouloir s'effacer de la situation.

Question 10 : *Quelle proposition évite le mieux le diagnostic prématuré ?*

- A. Emma présente une dépression caractérisée.
- B. Emma est probablement évitante.
- C. Le monde universitaire apparaît comme difficilement habitable et associé à une exposition à autrui.
- D. Emma est dans le déni.

Observation 2 — Karim

Karim, 29 ans, travaille depuis quatre ans dans une entreprise de conseil. Il explique :
« Je réponds aux mails jusqu'à minuit. Même quand je suis chez moi, j'ai l'impression que le travail continue dans ma tête. Je fais des listes pour ne rien oublier, mais plus j'en fais, plus j'ai peur qu'un détail m'échappe. »

Il ajoute : « Quand mon téléphone vibre, mon corps se tend immédiatement. Je ne peux pas vraiment me reposer. Si je ralentis, j'ai l'impression que tout va s'écrouler. Les autres me disent de lâcher prise, mais ils ne comprennent pas : si je ne contrôle pas, quelque chose va forcément déraiper. »

Question 11 : *Quels indices relèvent du vécu brut ?*

- A. « Je réponds aux mails jusqu'à minuit. »
- B. « Il présente un trouble obsessionnel compulsif. »
- C. « Mon corps se tend immédiatement. »
- D. « Il veut tout contrôler parce qu'il manque de sécurité intérieure. »

Question 12 : *Quelle dimension est particulièrement présente dans : « Même quand je suis chez moi, j'ai l'impression que le travail continue dans ma tête » ?*

- A. Spatialité, car la frontière entre espace professionnel et espace privé semble fragilisée.
- B. Temporalité, car le travail déborde le temps supposé du repos.
- C. Mondanité, car le monde se donne comme envahi par les exigences professionnelles.
- D. Diagnostic, car cette phrase suffit à conclure à un burn-out.

Question 13 : *Quelle formulation décrit correctement le rapport au corps de Karim ?*

- A. Le corps réagit immédiatement à la vibration du téléphone.
- B. Le corps apparaît tendu et mobilisé par l'alerte.
- C. Le corps est absent du matériau.
- D. Le corps peut être décrit comme engagé dans une vigilance.

Question 14 : *Quelle tension structurante semble pertinente ?*

- A. Maîtrise / débordement
- B. Repos / effondrement redouté
- C. Joie / tristesse
- D. Contrôle / risque de dérapage

Question 15 : *Quelle proposition est un thème, mais pas encore une tension structurante ?*

- A. Le contrôle
- B. Maîtrise / débordement
- C. Repos / menace d'effondrement
- D. Engagement professionnel / impossibilité de se retirer

Question 16 : *Quelle formulation est méthodologiquement incorrecte ?*

- A. Le travail semble envahir des espaces et des temps qui pourraient être associés au repos.
- B. Le téléphone fonctionne comme un déclencheur corporel d'alerte.
- C. Karim a une personnalité obsessionnelle.
- D. Le repos apparaît difficilement habitable.

Question 17 : *Quels éléments peuvent être rattachés à la temporalité ?*

- A. « Je réponds aux mails jusqu'à minuit. »
- B. « Je ne peux pas vraiment me reposer. »
- C. « Quand mon téléphone vibre, mon corps se tend immédiatement. »
- D. « Si je ralentis, j'ai l'impression que tout va s'écrouler. »

Question 18 : *Quelle formulation correspond à une organisation du vécu dans la mondanité ?*

- A. Le monde professionnel apparaît comme continu, exigeant et difficile à mettre à distance.
- B. Karim est incapable de profiter de la vie.
- C. L'environnement semble organisé autour d'une menace de débordement permanent.
- D. Karim souffre nécessairement d'un burn-out sévère.

Question 19 : *Quelle structure de vécu est la plus conforme à la méthode ?*

- A. Karim est prisonnier de son perfectionnisme pathologique.
- B. Le vécu de Karim semble organisé autour d'une tension entre maîtrise et débordement. Le contrôle permet de maintenir une forme de continuité et d'éviter l'effondrement redouté, mais il limite le repos, la disponibilité corporelle et la possibilité d'habiter un espace privé distinct du travail.
- C. Karim travaille trop parce qu'il veut être reconnu.
- D. Karim présente un trouble anxieux généralisé avec traits obsessionnels.

Question 20 : *Parmi les propositions suivantes, lesquelles correspondent à des erreurs méthodologiques fréquentes ?*

- A. Commencer par un diagnostic.
- B. Confondre une tension structurante avec un simple thème.
- C. Ancrer une formulation dans des éléments précis du texte.
- D. Déduire une intention non présente dans le matériau.

QCM 2

Consigne : pour chaque question, sélectionner la ou les propositions exactes.

Observation 1 - Clara

Clara, 25 ans, a commencé un nouvel emploi il y a trois mois. Elle explique : « Le matin, je reste parfois devant la porte de l'immeuble. Je suis prête, mon sac est fait, mais au moment de sortir j'ai l'impression que la rue est trop ouverte. Je redescends alors chez moi et j'envoie un message pour dire que je serai en retard. » Elle ajoute : « Au bureau, je parle peu. Je choisis toujours une place près du mur. Quand quelqu'un vient derrière moi, je me raidis. Le soir, je suis soulagée de rentrer, mais mon appartement finit aussi par me sembler étroit. »

Question 1 : *Quelle formulation respecte le mieux la posture phénoménologique initiale ?*

- A. Clara présente une agoraphobie.
- B. Clara manque de courage pour sortir.
- C. La sortie apparaît comme un passage difficilement habitable, associé à une forte exposition.
- D. Clara refuse inconsciemment le monde du travail.

Question 2 : *Quels éléments relèvent du vécu brut ?*

- A. « Je reste parfois devant la porte de l'immeuble. »
- B. Elle souffre d'un trouble anxieux.
- C. « Quand quelqu'un vient derrière moi, je me raidis. »
- D. Elle recherche le contrôle parce qu'elle manque de sécurité.

Question 3 : *Quelles dimensions sont particulièrement sollicitées par « la rue est trop ouverte » ?*

- A. Spatialité
- B. Mondanité
- C. Corporéité
- D. Diagnostic

Question 4 : *Quelle formulation décrit correctement la corporéité de Clara ?*

- A. Le corps se raidit lorsque la proximité arrière augmente.
- B. Le corps apparaît engagé dans une vigilance défensive.
- C. Le corps est absent du récit.
- D. Clara somatise nécessairement un conflit inconscient.

Question 5 : *Quels indices peuvent être rattachés à l'altérité ?*

- A. Clara parle peu au bureau.
- B. Elle choisit une place près du mur.
- C. La venue de quelqu'un derrière elle modifie immédiatement son vécu corporel.
- D. Elle a un tempérament introverti.

Question 6 : *Quelle tension structurante paraît la plus pertinente ?*

- A. Protection / exposition
- B. Ouverture / fermeture
- C. Intelligence / manque d'intelligence
- D. Sortir / se remettre à l'abri

Question 7 : *Quelle proposition est un simple thème plutôt qu'une tension ?*

- A. La protection
- B. Protection / exposition
- C. Refuge / enfermement
- D. Approche / retrait

Question 8 : *Quelle organisation du vécu spatial est la plus juste ?*

- A. L'extérieur apparaît trop ouvert et le domicile fonctionne comme refuge, tout en pouvant devenir étroit.
- B. Clara déteste les espaces publics.
- C. Elle choisit le mur parce qu'elle est paranoïaque.
- D. Tous les espaces sont vécus exactement de la même façon.

Question 9 : *Quelle structure de vécu est la plus conforme à la méthode ?*

- A. Clara est anxieuse, évitante et dépendante.
- B. Le vécu semble organisé autour d'une tension entre exposition et protection. Le retrait et l'appui sur des limites spatiales permettent de réduire l'exposition, mais limitent la circulation, l'engagement professionnel et la possibilité d'habiter durablement un lieu.
- C. Clara ne sort pas parce qu'elle a peur du jugement.
- D. Clara présente une phobie sévère.

Question 10 : *Quelle erreur méthodologique contient : « Clara choisit le mur parce qu'elle craint d'être attaquée » ?*

- A. Une paraphrase fidèle
- B. Une causalité supposée
- C. Une description de la spatialité
- D. Un ancrage textuel suffisant

Observation 2 - Thomas

Thomas, 34 ans, vient consulter après une séparation. Il dit : « Je continue à aller travailler, à faire les courses, à voir mes enfants. Tout est organisé, mais j'ai l'impression de traverser mes journées sans y être vraiment. » Il ajoute : « Le soir, je remets souvent les mêmes photos. Je ne veux pas les ranger, mais je ne peux pas non plus les regarder longtemps. Le futur, je préfère ne pas y penser. Pour l'instant, je fais ce qu'il faut. »

Question 11 : *Quelle formulation initiale est la plus descriptive pour Thomas ?*

- A. Thomas est en dépression.
- B. Thomas traverse des activités maintenues avec un faible sentiment de présence à ce qu'il vit.

- C. Thomas nie sa séparation.
- D. Thomas est incapable de faire son deuil.

Question 12 : *Quels indices relèvent de l'ipséité ?*

- A. « Sans y être vraiment. »
- B. « Je fais ce qu'il faut. »
- C. « Je ne peux pas les regarder longtemps. »
- D. Thomas a une personnalité froide.

Question 13 : *Quels éléments relèvent de la temporalité ?*

- A. Le futur est tenu à distance.
- B. Les mêmes photos sont reprises le soir.
- C. Les journées restent organisées.
- D. Thomas est forcément mélancolique.

Question 14 : *Quelle tension traverse le rapport aux photos ?*

- A. Conserver / mettre à distance
- B. Regarder / ne pas pouvoir regarder longtemps
- C. Présence du passé / impossibilité de s'y maintenir
- D. Joie / colère

Question 15 : *Quelle dimension est particulièrement engagée par « je traverse mes journées sans y être vraiment » ?*

- A. Ipséité
- B. Temporalité
- C. Mondanéité
- D. Toutes les réponses précédentes

Question 16 : *Quelle formulation décrit correctement le rapport au monde ?*

- A. Le monde quotidien demeure praticable, mais apparaît faiblement habité subjectivement.
- B. Le monde est totalement détruit.
- C. Thomas refuse le réel.
- D. La séparation explique mécaniquement tout son fonctionnement.

Question 17 : *Quelle tension principale paraît la plus pertinente ?*

- A. Continuité des conduites / retrait de la présence subjective
- B. Maintien / désengagement
- C. Passé conservé / avenir suspendu
- D. Extraversion / introversion

Question 18 : *Quelle formulation est trop générale pour constituer une structure de vécu ?*

- A. Thomas est en difficulté.
- B. Le vécu est organisé autour d'un maintien fonctionnel du quotidien associé à un retrait de la présence subjective.

- C. Cette organisation préserve une continuité minimale, mais limite l'appropriation du présent et l'ouverture vers l'avenir.
- D. Les photos maintiennent une présence du passé à la fois recherchée et difficilement soutenable.

Question 19 : *Quelle structure de vécu est la plus conforme ?*

- A. Thomas souffre d'un deuil pathologique.
- B. Thomas évite l'avenir parce qu'il est dépendant affectivement.
- C. Le vécu semble organisé autour d'une continuité pratique sans pleine appropriation subjective. Le maintien des routines et des traces du passé permet de conserver une forme de stabilité, mais limite l'engagement dans le présent et l'ouverture vers un avenir pensable.
- D. Thomas est triste et nostalgique.

Question 20 : *Parmi les propositions suivantes, lesquelles correspondent à des exigences méthodologiques ?*

- A. Rester ancré dans les formulations du sujet.
- B. Hiérarchiser les tensions.
- C. Déduire les intentions cachées.
- D. Distinguer description et diagnostic.

QCM 3

Consigne : pour chaque question, sélectionner la ou les propositions exactes.

Observation 1 - Nadia

Nadia, 31 ans, travaille dans une médiathèque. Elle raconte : « Quand plusieurs personnes me parlent en même temps, les voix deviennent comme une masse. Je n'arrive plus à savoir à qui répondre. Mon corps chauffe, je serre les mains sous la table et j'attends que ça passe. » Elle ajoute : « Après, je repense à chaque phrase. Je me demande si j'ai répondu correctement. Le lendemain, avant d'arriver, la scène est déjà là. »

Question 1 : *Quels indices relèvent directement du vécu brut de Nadia ?*

- A. Les voix deviennent comme une masse.
- B. Elle présente une hypersensibilité pathologique.
- C. Son corps chauffe.
- D. Elle serre les mains sous la table.

Question 2 : *Quelle dimension est particulièrement présente dans « les voix deviennent comme une masse » ?*

- A. Mondanité
- B. Altérité
- C. Corporéité
- D. Toutes les réponses précédentes

Question 3 : *Quelle formulation décrit le mieux la corporéité ?*

- A. Le corps apparaît chauffé, serré et retenu dans l'attente.
- B. Nadia fait une crise de panique certaine.
- C. Le corps est un simple symptôme sans lien avec le monde vécu.
- D. Le corps participe au mode de protection face à la saturation.

Question 4 : *Quels éléments relèvent de la temporalité ?*

- A. La scène est reprise après coup.
- B. Le lendemain est anticipé à partir de la scène précédente.
- C. Nadia attend que la saturation passe.
- D. Nadia a toujours été anxieuse.

Question 5 : *Quelle tension structurante paraît centrale ?*

- A. Saturation / tentative de contenance
- B. Adresse à autrui / impossibilité de répondre
- C. Présent de la scène / reprise anticipative
- D. Courage / lâcheté

Question 6 : *Quelle proposition psychologise prématurément ?*

- A. La pluralité des voix est difficile à différencier.
- B. Nadia cherche à être parfaite pour compenser un manque d'estime d'elle-même.
- C. Le corps se retient pendant que la situation est attendue.

D. L'après-coup prolonge la scène dans le temps.

Question 7 : *Quelle organisation du rapport à autrui est la plus juste ?*

- A. Autrui apparaît comme une pluralité difficile à différencier et à laquelle répondre.
- B. Nadia déteste les gens.
- C. Les autres sont nécessairement hostiles.
- D. Le rapport à autrui n'est pas présent.

Question 8 : *Quelle proposition formule un thème et non une tension ?*

- A. La saturation
- B. Saturation / contenance
- C. Répondre / ne plus savoir à qui répondre
- D. Exposition / retrait corporel

Question 9 : *Quelle structure de vécu est la plus conforme ?*

- A. Nadia a un trouble anxieux social.
- B. Le vécu semble organisé autour d'une saturation de la situation intersubjective et d'un effort de contenance corporelle. La retenue permet de traverser la scène, mais celle-ci se prolonge après coup et anticipe les rencontres suivantes, limitant la disponibilité à autrui.
- C. Nadia manque de confiance et rumine.
- D. Nadia refuse de communiquer.

Question 10 : *Quelle vérification finale convient à cette analyse ?*

- A. Les formulations sont-elles ancrées dans le texte ?
- B. Ai-je posé le diagnostic le plus probable ?
- C. Ai-je distingué thème et tension ?
- D. Ai-je supposé une intention cachée ?

Observation 2 - Julien

Julien, 40 ans, a repris une activité après une longue période d'arrêt. Il dit : « J'ai besoin que tout soit prévu. Je note l'heure, le trajet, l'endroit où je vais m'asseoir. Quand quelque chose change, même peu, j'ai l'impression de perdre le fil. » Il poursuit : « Pourtant, quand tout se déroule comme prévu, je me sens enfermé dans mon propre programme. J'aimerais improviser, mais au moment de le faire, je reviens au plan. »

Question 11 : *Quelle formulation initiale est la plus descriptive pour Julien ?*

- A. Julien est obsessionnel.
- B. Le déroulement de l'action dépend fortement d'un programme préalable.
- C. Julien contrôle tout parce qu'il a peur de l'échec.
- D. Julien refuse la spontanéité.

Question 12 : *Quelles dimensions sont engagées par la préparation du trajet et de la place ?*

- A. Temporalité
- B. Spatialité
- C. Mondanité

D. Aucune

Question 13 : *Quelle tension structurante est explicitement présente ?*

- A. Prévisibilité / improvisation
- B. Sécurité du plan / enfermement dans le plan
- C. Continuité / perte du fil
- D. Force / faiblesse

Question 14 : *Quelle formulation décrit l'ipséité ?*

- A. Julien se vit comme dépendant du plan pour maintenir le fil de son action.
- B. Julien est une personne rigide.
- C. Le sentiment d'être auteur de l'improvisation semble limité au moment d'agir.
- D. Julien est forcément atteint d'un trouble de la personnalité.

Question 15 : *Quelle proposition est causalement abusive ?*

- A. Le changement fragilise la continuité de l'action.
- B. Le plan rend la situation habitable.
- C. Julien planifie parce que ses parents étaient imprévisibles.
- D. L'improvisation reste souhaitée mais difficilement actualisable.

Question 16 : *Quelle organisation du vécu spatial est la plus juste ?*

- A. L'espace est préparé à l'avance par le trajet et la place à occuper.
- B. L'espace est totalement fermé.
- C. La place choisie participe à la continuité du déroulement prévu.
- D. Julien ne sait pas se repérer.

Question 17 : *Ce que le plan permet peut être formulé ainsi :*

- A. Il soutient la continuité et réduit l'incertitude.
- B. Il guérit Julien.
- C. Il rend l'action possible.
- D. Il prouve un diagnostic.

Question 18 : *Ce que le plan limite peut être formulé ainsi :*

- A. La possibilité d'improviser.
- B. L'ouverture à l'imprévu.
- C. Le sentiment de liberté dans l'action.
- D. L'intelligence de Julien.

Question 19 : *Quelle structure de vécu est la plus conforme ?*

- A. Julien souffre de rigidité obsessionnelle.
- B. Le vécu semble organisé autour d'une recherche de continuité par la prévision, en tension avec un désir d'ouverture à l'imprévu. Le plan rend l'action possible et protège de la perte du fil, mais il peut devenir un cadre enfermant qui réduit l'agentivité et l'improvisation.
- C. Julien planifie parce qu'il n'aime pas les surprises.
- D. Julien est perfectionniste.

Question 20 : *Quelles erreurs faut-il éviter dans ce cas ?*

- A. Transformer le plan en symptôme isolé.
- B. Oublier sa fonction protectrice.
- C. Décrire aussi ses limites.
- D. Dédire une cause biographique absente.

QCM 4

Consigne : pour chaque question, sélectionner la ou les propositions exactes.

Observation 1 - Élise

Élise, 28 ans, enseigne depuis deux ans. Elle dit : « En classe, je parle, je réponds, je fais cours. Mais j'ai l'impression que ma voix part avant moi. Je m'entends parler comme si je suivais quelqu'un d'autre. » Elle ajoute : « Quand un élève me pose une question imprévue, je reviens d'un coup. Après le cours, je suis épuisée, comme si j'avais dû me rattraper toute l'heure. »

Question 1 : *Quelle formulation respecte la description initiale d'Élise ?*

- A. Élise présente une dissociation.
- B. La parole se déroule avec un sentiment réduit d'en être pleinement l'auteur.
- C. Élise joue un rôle pour séduire ses élèves.
- D. Élise est épuisée parce qu'elle n'aime pas enseigner.

Question 2 : *Quels indices relèvent de l'ipséité ?*

- A. « Ma voix part avant moi. »
- B. « Je m'entends parler comme si je suivais quelqu'un d'autre. »
- C. La question imprévue la fait revenir d'un coup.
- D. Élise a une personnalité fragile.

Question 3 : *Quelle dimension est également engagée par la voix ?*

- A. Corporéité
- B. Altérité
- C. Mondanéité
- D. Toutes les réponses précédentes

Question 4 : *Quelle tension structurante paraît centrale ?*

- A. Automatisme / reprise de présence
- B. Déroulement de la parole / appropriation de la parole
- C. Continuité du cours / effort pour se rattraper
- D. Compétence / incompétence

Question 5 : *Quelle formulation décrit le rôle de la question imprévue ?*

- A. Elle interrompt le déroulement automatique et réengage Élise dans la situation.
- B. Elle prouve que les élèves sont menaçants.
- C. Elle fonctionne comme une bascule dans le vécu.
- D. Elle révèle nécessairement un traumatisme.

Question 6 : *Quelle proposition relève d'un diagnostic prématuré ?*

- A. La présence à sa propre parole semble fluctuante.
- B. Le cours est assuré malgré une appropriation vécue fragile.
- C. Élise souffre d'un trouble dissociatif.
- D. L'épuisement survient après un effort de reprise.

Question 7 : *Quelle formulation de la corporéité est correcte ?*

- A. La voix apparaît partiellement désappropriée.
- B. Le corps est totalement absent.
- C. L'épuisement après le cours indique un coût corporel du maintien de la situation.
- D. Élise simule sa fatigue.

Question 8 : *Quelle structure de vécu est la plus conforme ?*

- A. Élise est dissociée et fragile.
- B. Le vécu semble organisé autour d'une continuité fonctionnelle de l'action en tension avec une appropriation fluctuante de la parole. L'automatisme permet de maintenir le cours, mais exige des reprises soudaines de présence et se paie d'un épuisement important.
- C. Élise enseigne mécaniquement parce qu'elle a peur d'échouer.
- D. Élise n'est pas faite pour ce métier.

Question 9 : *Quelle proposition est insuffisamment ancrée ?*

- A. La voix semble précéder le sentiment d'agir.
- B. La question imprévue produit une reprise de présence.
- C. Élise a été humiliée à l'école et reproduit aujourd'hui cette scène.
- D. L'après-cours est marqué par l'épuisement.

Question 10 : *Quelles dimensions dominent dans cette observation ?*

- A. Ipséité
- B. Corporéité
- C. Temporalité de la bascule
- D. Diagnostic

Observation 2 - Marc

Marc, 52 ans, accompagne régulièrement son père malade. Il explique : « Je dois être disponible. Quand le téléphone sonne, tout le reste devient secondaire. Je peux annuler un repas ou quitter une réunion sans réfléchir. » Il ajoute : « Quand il ne m'appelle pas, je devrais être tranquille, mais j'attends quand même. Je n'arrive pas à commencer quelque chose qui demanderait d'être vraiment ailleurs. »

Question 11 : *Quelle formulation initiale est la plus descriptive pour Marc ?*

- A. Marc est dépendant de son père.
- B. La possibilité d'être appelé organise fortement sa disponibilité et ses activités.
- C. Marc se sacrifie par culpabilité.
- D. Marc souffre d'anxiété généralisée.

Question 12 : *Quels éléments relèvent de la temporalité ?*

- A. L'attente persiste même en l'absence d'appel.
- B. Le téléphone peut interrompre immédiatement l'activité en cours.
- C. Marc anticipe une disponibilité possible.

D. Marc a toujours été comme cela.

Question 13 : *Quelle formulation décrit le rapport au monde ?*

- A. Le monde quotidien est hiérarchisé par la possibilité de l'appel.
- B. Tout le reste devient secondaire lorsqu'il sonne.
- C. Le monde est complètement inexistant.
- D. Marc refuse toutes ses activités.

Question 14 : *Quelle tension structurante paraît pertinente ?*

- A. Disponibilité pour l'autre / impossibilité d'être ailleurs
- B. Attente / engagement dans une activité propre
- C. Réponse immédiate / continuité personnelle
- D. Gentillesse / méchanceté

Question 15 : *Quelle formulation décrit l'altérité ?*

- A. Le père apparaît comme une présence potentielle qui organise même les moments sans appel.
- B. Le père est forcément intrusif.
- C. L'appel d'autrui a priorité sur les engagements en cours.
- D. Marc déteste son père.

Question 16 : *Quelle proposition constitue une cause supposée ?*

- A. Marc attend même lorsque le téléphone ne sonne pas.
- B. Il annule parfois des activités.
- C. Il reste disponible parce qu'il cherche l'amour de son père.
- D. L'engagement dans une activité propre est limité.

Question 17 : *Ce que cette organisation permet est :*

- A. Répondre rapidement aux besoins du père.
- B. Maintenir une continuité de disponibilité.
- C. Préserver toutes les activités personnelles.
- D. Éviter toute fatigue.

Question 18 : *Ce qu'elle limite est :*

- A. L'engagement dans des activités nécessitant une présence ailleurs.
- B. La continuité des repas ou réunions.
- C. La disponibilité au monde propre de Marc.
- D. Toute relation avec son père.

Question 19 : *Quelle structure de vécu est la plus conforme ?*

- A. Marc est codépendant.
- B. Le vécu semble organisé autour d'une disponibilité anticipée à l'appel de l'autre. Cette organisation rend possible une réponse immédiate et soutient le lien, mais maintient Marc dans une attente qui fragilise la continuité de ses activités et la possibilité d'habiter un monde propre.

- C. Marc agit ainsi parce qu'il se sent coupable.
- D. Marc est trop gentil.

Question 20 : *Parmi ces formulations, laquelle transforme une tension en catégorie ?*

- A. Disponibilité / engagement propre
- B. Attente / action
- C. Marc est dépendant affectif
- D. Présence à l'autre / absence à soi

QCM 5

Consigne : pour chaque question, sélectionner la ou les propositions exactes.

Observation 1 - Inès

Inès, 23 ans, prépare un concours. Elle explique : « Je travaille toute la journée, mais je ne sais jamais si j'ai vraiment commencé. Je relis le programme, je range mes fiches, je refais mon planning. Quand enfin j'ouvre un chapitre, je pense déjà à tout ce qui reste. » Elle ajoute : « Le soir, j'ai l'impression d'avoir été occupée sans avoir avancé. Le lendemain devient immédiatement une nouvelle tentative pour rattraper la veille. »

Question 1 : Quelle formulation respecte le mieux la posture initiale pour Inès ?

- A. Inès procrastine par peur de l'échec.
- B. L'activité est dense mais l'entrée dans le travail reste difficile à identifier et à stabiliser.
- C. Inès manque de motivation.
- D. Inès présente un trouble obsessionnel.

Question 2 : Quels éléments constituent du vécu brut ?

- A. Elle relit le programme.
- B. Elle range ses fiches.
- C. Elle refait son planning.
- D. Elle compense une faible estime de soi.

Question 3 : Quelle dimension domine dans « le lendemain devient une nouvelle tentative pour rattraper la veille » ?

- A. Temporalité
- B. Spatialité
- C. Altérité
- D. Corporéité

Question 4 : Quelle organisation du temps est la plus juste ?

- A. Le présent est envahi par ce qui reste à faire.
- B. Le lendemain est orienté par le rattrapage de la veille.
- C. L'avancée est difficilement éprouvée.
- D. Le temps est vécu comme parfaitement ouvert.

Question 5 : Quelle tension structurante paraît centrale ?

- A. Occupation / absence d'avancée
- B. Préparation / engagement effectif
- C. Tentative de maîtrise / multiplication de ce qui reste
- D. Intelligence / paresse

Question 6 : Quelle proposition décrit l'ipséité ?

- A. Inès peine à se reconnaître comme ayant réellement commencé ou avancé.
- B. Inès est perfectionniste.
- C. Le sentiment d'être l'auteur d'une progression reste fragile.

D. Inès veut inconsciemment échouer.

Question 7 : Quelle proposition est un simple thème ?

- A. Le planning
- B. Préparer / commencer
- C. Occupation / progression
- D. Maîtrise / débordement

Question 8 : Ce que l'organisation par le planning permet est :

- A. Donner une forme à la masse du travail.
- B. Maintenir une impression d'activité.
- C. Garantir la réussite au concours.
- D. Supprimer toute incertitude.

Question 9 : Ce qu'elle limite est :

- A. L'entrée effective dans le chapitre.
- B. L'expérience d'une progression accomplie.
- C. L'ouverture du présent à une tâche délimitée.
- D. Toute capacité de lecture.

Question 10 : Quelle structure de vécu est la plus conforme ?

- A. Inès est anxieuse et procrastinatrice.
- B. Le vécu semble organisé autour d'un effort de maîtrise du travail par la préparation, en tension avec la difficulté à entrer dans une action délimitée. L'organisation maintient une activité et contient l'ampleur du programme, mais nourrit un temps de rattrapage où l'avancée reste difficile à éprouver.
- C. Inès range ses fiches parce qu'elle a peur de réussir.
- D. Inès présente un trouble de l'attention.

Observation 2 - Paul

Paul, 46 ans, a déménagé récemment. Il dit : « Dans l'ancien quartier, je pouvais sortir sans réfléchir. Ici, chaque trajet demande une décision. Je regarde longtemps la carte, puis je reste parfois chez moi. » Il ajoute : « Mon appartement est neuf, propre, pratique, mais rien ne m'y appelle. J'ai posé quelques objets sur les étagères, comme pour prouver que j'habite là. Quand des amis viennent, je me sens davantage chez moi, puis le silence revient après leur départ. »

Question 11 : Quelle formulation initiale est la plus descriptive pour Paul ?

- A. Paul est déprimé depuis son déménagement.
- B. Le nouvel environnement demande un effort d'orientation et reste faiblement familial.
- C. Paul refuse de s'adapter.
- D. Paul souffre d'un trouble de l'attachement.

Question 12 : Quels indices relèvent de la spatialité ?

- A. Chaque trajet demande une décision.

- B. Il regarde longtemps la carte.
- C. Il reste parfois chez lui.
- D. Il a un caractère casanier.

Question 13 : Quelle formulation décrit la mondanéité ?

- A. Le nouveau quartier apparaît peu familier et peu appelant.
- B. L'appartement est pratique mais faiblement investi comme monde propre.
- C. Le monde est totalement hostile.
- D. Paul déteste nécessairement sa nouvelle ville.

Question 14 : Quelle dimension est engagée par « comme pour prouver que j'habite là » ?

- A. Ipséité
- B. Spatialité
- C. Mondanéité
- D. Toutes les réponses précédentes

Question 15 : Quel rôle joue la présence des amis ?

- A. Elle augmente temporairement le sentiment d'être chez soi.
- B. Elle transforme l'appartement en espace relationnellement habitable.
- C. Elle prouve que Paul est dépendant.
- D. Elle modifie le rapport au silence après leur départ.

Question 16 : Quelle tension structurante paraît la plus pertinente ?

- A. Habiter / ne pas encore se sentir chez soi
- B. Familiarité / étrangeté
- C. Présence relationnelle / retour du silence
- D. Ville / campagne

Question 17 : Quelle proposition formule une intention non soutenue ?

- A. Paul pose des objets sur les étagères.
- B. Ces objets participent à une tentative d'appropriation.
- C. Paul invite ses amis pour les empêcher de l'abandonner.
- D. Le silence modifie le sentiment d'habiter.

Question 18 : Ce que le maintien à domicile permet peut être formulé ainsi :

- A. Éviter l'effort d'orientation de certains trajets.
- B. Conserver un espace prévisible.
- C. Construire automatiquement un chez-soi.
- D. Rendre le quartier immédiatement familier.

Question 19 : Quelle structure de vécu est la plus conforme ?

- A. Paul est inadapté et dépendant de ses amis.
- B. Le vécu semble organisé autour d'une tension entre la nécessité d'habiter un nouvel espace et une familiarité qui ne s'est pas encore constituée. Les repères, les objets et la présence

des amis rendent temporairement le lieu plus habitable, mais l'orientation demeure coûteuse et le sentiment d'être chez soi reste fragile.

C. Paul reste chez lui parce qu'il regrette son ancienne vie.

D. Paul présente un épisode dépressif.

Question 20 : Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont conformes à la méthode ?

A. Retenir seulement les dimensions soutenues par le texte.

B. Formuler ce que l'organisation permet et limite.

C. Multiplier les diagnostics pour être complet.

D. Distinguer une tension d'un thème.

Table des matières

ORGANISATION DES TD.....	1
Objectifs.....	1
Supports et modalités de travail.....	1
Consignes générales.....	1
Critères d'évaluation du travail en TD.....	1
FICHES DE MÉTHODE.....	2
Principes de l'analyse phénoménologique — synthèse et formalisation pour les TD.....	2
<i>Etape 1. Décrire le vécu. Repérage phénoménologique.....</i>	<i>2</i>
<i>Etape 2. Organiser selon les dimensions du vécu. Les existentiels.....</i>	<i>3</i>
<i>Etape 3. Dégager les tensions structurantes.....</i>	<i>5</i>
<i>Etape 4. Formuler synthétiquement la structure du vécu.....</i>	<i>6</i>
Points de vigilance méthodologique.....	7
<i>Entrer trop rapidement par le diagnostic.....</i>	<i>7</i>
<i>Transformer une tension en catégorie clinique.....</i>	<i>7</i>
<i>Confondre "thème" et "tension".....</i>	<i>7</i>
<i>Remplir artificiellement toutes les dimensions.....</i>	<i>7</i>
<i>Paraphraser sans organiser.....</i>	<i>7</i>
<i>Formuler une cause au lieu d'une description.....</i>	<i>8</i>
<i>Déduire une intention non présente dans le matériau.....</i>	<i>8</i>
<i>« Psychologiser » trop vite.....</i>	<i>8</i>
<i>Multiplier les tensions sans les hiérarchiser.....</i>	<i>8</i>
<i>Produire une structure de vécu trop générale.....</i>	<i>8</i>
Vérification finale.....	9
EXEMPLE.....	10
Observation.....	10
Étape 1 — Décrire le vécu. Repérage phénoménologique.....	10
Étape 2 — Organiser selon les dimensions du vécu.....	12
<i>Organisation du vécu par dimension.....</i>	<i>12</i>
<i>Temporalité.....</i>	<i>12</i>
<i>Spatialité.....</i>	<i>12</i>
<i>Corporéité.....</i>	<i>12</i>
<i>Altérité.....</i>	<i>12</i>
<i>Ipséité.....</i>	<i>12</i>
<i>Mondanéité.....</i>	<i>13</i>
<i>Éléments qui traversent plusieurs dimensions.....</i>	<i>13</i>
<i>Tableau synthétique : variante 1.....</i>	<i>14</i>
<i>Tableau synthétique : variante 2.....</i>	<i>16</i>
Étape 3 — Tension structurante.....	18
<i>Nom de la tension.....</i>	<i>18</i>
<i>Polarité 1 : continuité apparente.....</i>	<i>18</i>
<i>Polarité 2 : non-coïncidence avec soi.....</i>	<i>18</i>
<i>Ce que cette tension permet.....</i>	<i>18</i>
<i>Ce qu'elle limite.....</i>	<i>18</i>
<i>Dimensions concernées.....</i>	<i>18</i>
Étape 4 — Structure de vécu (formulation synthétique).....	19

Vérification finale.....	19
OBSERVATIONS.....	21
1. Mme L., 42 ans.....	21
2. « Matin sans forme ».....	21
3. Madeleine, 50 ans.....	21
4. Mr. D.....	21
5. « À distance des autres ».....	21
6. « Vérifier, remettre en ordre ».....	22
7. « La salle de cours ».....	22
8. « Quand je commence quelque chose de nouveau... ».....	22
9. Camille.....	22
10. « Décisions impossibles ».....	23
11. M. V., 28 ans.....	23
12. Mme X.....	23
13. M. R., 28 ans.....	23
14. La veste dans l'entrée.....	23
15. Dans le vestiaire.....	24
16. Trop de bruit.....	24
17. Le message non envoyé.....	24
18. Une journée cadrée.....	24
19. Le quai.....	24
20. La table préparée.....	24
21. La réponse attendue.....	25
22. La pièce trop pleine.....	25
23. Le dimanche immobile.....	25
24. La lumière du supermarché.....	25
25. « Avant d'ouvrir la messagerie ».....	25
TEXTES (PROSE).....	27
A. « À l'hôpital » - Henri Michaux (1935).....	27
B. Bartleby - Herman Melville (1853).....	27
C. La Nausée - Jean-Paul Sartre (1938).....	27
D. Oblomov - Ivan Gontcharov (1859).....	28
E. Les Liaisons dangereuses - Choderlos de Laclos (1782).....	28
F. Les Vagues - Virginia Woolf (1931).....	28
G. Mrs Dalloway - Virginia Woolf (1925).....	28
H. Les Âmes mortes - Nikolai Gogol (1842).....	29
I. Le Journal d'un fou - Nikolai Gogol (1835).....	29
J. Walden - Henry David Thoreau (1854).....	29
TEXTES (HAÏKUS).....	30
« Nuit de fleurs ».....	30
« Le combat de taureaux terminé ».....	30
« Sous la lampe d'automne ».....	30
« Je l'ai tuée ».....	31
« Bain du solstice d'hiver ».....	31
DE LA CLINIQUE À LA PSYCHOPATHOLOGIE.....	32
Claire, 40 ans.....	32

Clinique phénoménologique.....	33
Analyse existentielle.....	33
Temporalité.....	33
Spatialité.....	33
Corporéité.....	33
Altérité.....	33
Ipséité.....	33
Mondanéité.....	33
Tension structurante.....	33
Structure de vécu et formulation existentielle.....	33
Psychopathologie psychodynamique.....	33
Psychopathologie cognitive.....	33
Psychopathologie anthropo-phénoménologique.....	33
Psychopathologie neuro-phénoménologique.....	33
Hypothèses diagnostiques.....	33
Pierre, 27 ans.....	34
Clinique phénoménologique.....	34
Analyse existentielle.....	34
Temporalité.....	34
Spatialité.....	34
Corporéité.....	34
Altérité.....	34
Ipséité.....	34
Mondanéité.....	34
Tension structurante.....	34
Structure de vécu et formulation existentielle.....	34
Psychopathologie psychodynamique.....	34
Psychopathologie cognitive.....	34
Psychopathologie anthropo-phénoménologique.....	34
Psychopathologie neuro-phénoménologique.....	34
Hypothèses diagnostiques.....	34
Jean, 50 ans.....	36
Clinique phénoménologique.....	37
Analyse existentielle.....	37
Temporalité.....	37
Spatialité.....	37
Corporéité.....	37
Altérité.....	37
Ipséité.....	37
Mondanéité.....	37
Tension structurante.....	37
Structure de vécu et formulation existentielle.....	37
Psychopathologie psychodynamique.....	37
Psychopathologie cognitive.....	37
Psychopathologie anthropo-phénoménologique.....	37
Psychopathologie neuro-phénoménologique.....	37
Hypothèses diagnostiques.....	37
Monsieur D., 38 ans.....	38

<i>Clinique phénoménologique</i>	38
<i>Analyse existentielle</i>	38
<i>Temporalité</i>	38
<i>Spatialité</i>	38
<i>Corporéité</i>	38
<i>Altérité</i>	38
<i>Ipséité</i>	38
<i>Mondanéité</i>	38
<i>Tension structurante</i>	38
<i>Structure de vécu et formulation existentielle</i>	38
<i>Psychopathologie psychodynamique</i>	38
<i>Psychopathologie cognitive</i>	38
<i>Psychopathologie anthropo-phénoménologique</i>	38
<i>Psychopathologie neuro-phénoménologique</i>	38
<i>Hypothèses diagnostiques</i>	38
Mme R., 35 ans.....	39
<i>Clinique phénoménologique</i>	40
<i>Analyse existentielle</i>	40
<i>Temporalité</i>	40
<i>Spatialité</i>	40
<i>Corporéité</i>	40
<i>Altérité</i>	40
<i>Ipséité</i>	40
<i>Mondanéité</i>	40
<i>Tension structurante</i>	40
<i>Structure de vécu et formulation existentielle</i>	40
<i>Psychopathologie psychodynamique</i>	40
<i>Psychopathologie cognitive</i>	40
<i>Psychopathologie anthropo-phénoménologique</i>	40
<i>Psychopathologie neuro-phénoménologique</i>	40
<i>Hypothèses diagnostiques</i>	40
Monsieur L., 27 ans.....	41
QCM 1	42
Observation 1 — Emma.....	42
Observation 2 — Karim.....	43
QCM 2	46
Observation 1 - Clara.....	46
Observation 2 - Thomas.....	47
QCM 3	50
Observation 1 - Nadia.....	50
Observation 2 - Julien.....	51
QCM 4	54
Observation 1 - Élise.....	54
Observation 2 - Marc.....	55
QCM 5	58
Observation 1 - Inès.....	58

Observation 2 - Paul.....	59
Table des matières.....	62

